

## 비계내과 1주차 SUMMARY

### [1] 총론

#### 1. 비계내과학

##### ✓ 정의

- 구강, 식도, 위, 십이지장, 췌장, 소장, 대장, 항문 등 소화기에 관련된 질병을 연구하는 학문  
→ 소화기 질병을 볼 때는 비, 위 뿐만 아니라 간, 담 등을 연계하여 봐야 함

##### ✓ 비위병 진단 및 치료접근 방법

##### ① 항상성(Homeostasis)

📖 비위병의 진단과 치료 접근 방법에 대해 쓰시오 [17]

자극에 의한 평형상태 소실 → 수용체가 변화 감지 → 조절기관으로 자극 전달  
→ 조절기관에서 반응기로 자극 전달 → 평형상태 유지반응 → 불균형 상태 해결

- 질병 = 생리적 범위에서 벗어난 채로 머물며 증상을 나타내는 것  
↳ 항상성 = 병리적 상태에서 다시 생리적 범위로 돌아오게 하는 것  
→ 외과적 처치가 필요하지 않은 대부분의 기능성 질환을 치료하는 최종 목표는 환자의 항상성을 되돌리는 데에 있음
- 항상성은 자율신경계, 호르몬에 의해 조절됨
- ② 소화기계에 대한 이해 - 간, 담, 비, 위, 췌장 (원인)  
- 소화기는 간담비위체가 서로 관여하므로 각 기관의 해부생리, 병리까지 모두 알아야 함

##### ③ 한의학적 정체관

- 인체는 유기적 관계로 이루어져 있으므로 단순히 한 기관만 보는 것이 아닌 사람 전체를 봐야 함
- 환자의 증상에 따른 처방보다는 환자 전체적 상태를 보고 치법을 선택해야 환자가 잘 나옴

##### ④ 자율신경계와 Stress

- 입~항문까지 이어져 있는 소화기계는 stress에 거의 가장 많은 영향을 받는 곳임

##### ⑤ Exercise - 근육, core

- 소화기능이 약한 환자는 위장관 평활근 기능이 저하된 경우가 많으므로 평활근에 영향을 줄 수 있는 주변 코어근육 강화 운동을 할 경우 평활근에 자극을 주어 소화기능이 향상됨

##### ⑥ 순환(혈액, 림프)

- 기질적 변화 없이 나타나는 기능성 소화불량 환자의 경우 혈액순환만 잘 시켜줘도 증상이 완화됨
- 기능성 소화불량증, 과민성장증후군 등 환자에게 림프순환을 잘 시켜주는 것이 중요

##### ⑦ 호르몬 ex. 갑상선 호르몬 등

##### ⑧ 약물 drug

- 건강기능식품 등 약물을 남용하여 소화기 질환이 일어나는 경우 다

##### ✓ 비위병의 주요 질환 기능적 질환 > 기질적 질환

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 상부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>기능성 소화불량증, 위식도 역류질환</b> (상부질환)<br/>→ 비계내과에 오는 환자들의 절반에 해당 = 상부에서 대부분 차지하는 질환</li> <li>• 연하곤란 및 식도성 흉통, 위축성 위염, 위 위축, 장상피화생</li> <li>• 급만성 위염, 소화성 궤양, 복통<br/>→ 궤양, 위염 등의 경우 지속적 건강검진 등에 의해 환자들 많이 줄어들</li> </ul> |
| 하부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>과민성 장증후군, 설사, 변비</b> (하부질환)</li> <li>• <b>장관 과다가스</b><br/>→ 외식이 많아지는 등과 같은 식습관 변화와 밀접한 관계 다<br/>→ 과다가스로 인해 횡격막, 위완부까지 가스가 차올라 식욕부진, 소화불량, 오심구토 등을 유발</li> <li>• 췌장염 및 췌장암, 염증성 장 질환, 항문질환(치열, 치루 등)</li> </ul>   |
| 기타 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 구내염, 음식물 알레르기, 식중독</li> <li>• <b>식욕부진, 만성피로증후군, 체질개선, 면역력 강화</b></li> </ul>                                                                                                                                         |

##### ✓ 비위병의 식이습관

📖 비위병의 식이습관에 대해 쓰시오 [17]

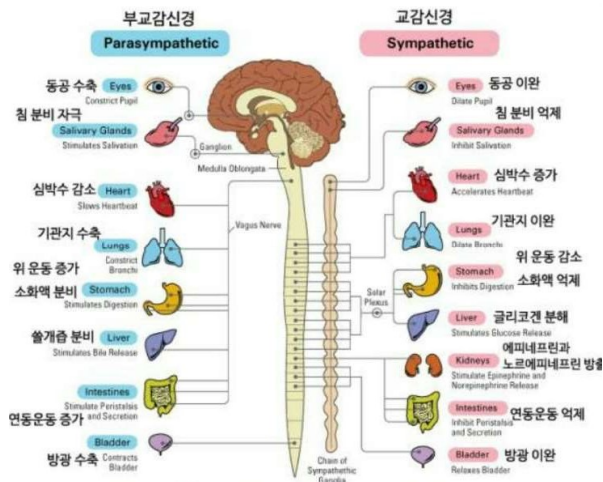
- |                   |                 |             |
|-------------------|-----------------|-------------|
| 1) 규칙적 식사시간       | 5) 자극성 음식       | 8) 절대금연, 금주 |
| 2) 일정한 식사량(과식 금지) | (맵, 짜, 카페인, 단단) | 9) 균형잡힌 식단  |
| 3) 다작(많이 씹기)      | 6) 야식금지         |             |
| 4) 식적 30분~식후 2시간  | 7) 충분한 수면       |             |

- 점막에 대한 작용을 담배가 하는데 위궤양 등과 같은 질환은 담배연기에 영향을 많이 받음

## ✓ 자율신경계

|    |       |     |                          |
|----|-------|-----|--------------------------|
| 신경 | 중추신경계 | CNS | 뇌                        |
|    |       |     | 척수                       |
|    | 말초신경계 | PNS | 체성신경계                    |
|    |       |     | 자율신경계      교감신경<br>부교감신경 |

- 구성: 교감신경, 부교감신경
- 역할: 항상성 유지 with 호르몬
- 방식: 교감, 부교감신경의 길항작용



| 부교감신경                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 안정 / 휴식 / 보존의 역할</li> <li>- 기시: 3, 7, 9, 10 뇌신경 (경추) + S2~4 천골신경</li> <li>- 10번 뇌신경이 전체 75%의 부교감신경</li> </ul>            |
| 교감신경                                                                                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- 운동 / 긴장 / 위협의 역할</li> <li>- 기시: T1~L2 신경 (흉부, 요추)</li> <li>- T1~12 흉부신경: 뇌신경 길항</li> <li>- L1~2 요추신경: 천골신경 길항</li> </ul> |

자율신경의 문란, 부조화로 인해서 생기는 소화불량 뿐만 아니라 불면, 갱년기 화병 등 자율신경실조증에 가장 좋은 운동은 척추운동!

대표적으로 앉아서 뒤구르기 등 척추운동을 꾸준히 해주는 것이 좋음

## 비계내과 2주차 SUMMARY

### 환자 문진부터 진단까지 tip

- ✓ 변증의 주증을 정확히 알고 주증의 원인을 아는 것이 중요
- ✓ 환자의 얘기를 듣기 위한 라포형성의 적절한 타이밍: 침 놓을 때
- ✓ 소화기 환자가 왔을 때 양방적 생리, 병리, 질환까지 잘 알아야 한다.
- ✓ 현대인들 외식문화의 발달 등으로 과다가스로 인해 횡격막과 위까지 압박하여 입맛 없는 경우 많음!  
↳ 식욕부진 약 주는 것 X 가스 빼내는 약 O
- ✓ 변증뿐 아니라 복진 등을 이용해 환자의 이상 상태 잘 파악해야 함
- ✓ 환자의 증상을 일으키는 정확한 원인을 파악해 치료법 정해야 함  
↳ ex) 위장운동이 잘 되지 않는 환자에게 승마운동 권해보기
- ✓ 문진 시 환자의 생활습관 등을 잘 알아두도록 해야 함

## 비, 위, 소장, 대장의 증후 및 변증시치

### 1. 비병

- 허증: 脾氣虛弱 脾氣下陷 脾陽不振 脾虛水種 脾不統血 脾陰虛
- 실증: 寒濕困脾 濕熱傷脾

### 1) 허증

#### (1) 비기허약

- ✓ 소화관 흡수력의 저하와 함께 전신적인 氣虛의 증후를 수반함
- ✓ 소화관의 연동운동 감약에 의한 위장의 氣滯증후나 진액수송 또는 수분흡수의 기능 저하로 인해 留飲, 痰濕, 水腫 등이 수반되는 경우가 많음

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 주증   | 面色萎黃, 納少便溏, 四肢無力, 舌淡, 苔白  |
| 검증   | 少氣懶語, 食後腹脹, 肌肉消瘦, 脈濡緩     |
| 임상특징 | 納少便糖 (비기허약이 발전되면 비기하함이 됨) |

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 치법        | 補氣健脾                               |
| 대표 방제     | 參苓白朮散, 四君子湯                        |
| 현대 의학적 고찰 | 만성위염, 만성장염, 위십이지장궤양, 위십이지장궤양, 만성간염 |

- ☑ 비기허라고 했지만 기허증의 변증 증상이 다 있음
- ☑ 보약을 먹겠다고 오는 환자, 소화기가 안 좋은 환자, 소화가 잘 안되는 환자가 왔을 때 소화기 약을 줘야 하는가 체력을 좋아지게 하는 항상성 원리의 약을 줘야하는가 에 대해 고민해 볼 필요가 있음
- ☑ 삼령백출산 읽어보기

## (2) 비기하함 (中氣下陷)

- ✓ 비기허가 발전되어 升清 기능이 감약된 것
- ✓ 횡문근이나 평활근 긴장이 현저학 저하되어 발생된 증후

|           |                                                         |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| 주증        | 久湯, 脫肛, 子宮下垂, 脛腹墜脹                                      |
| 검증        | 頭昏, 聲低, 氣短, 四肢無力, 舌淡紅, 苔薄白, 脈虛緩                         |
| 임상특징      | 중기의 托舉 기능의 감약으로 인한 내장하수                                 |
| 치법        | 補氣健脾, 升陽舉陷                                              |
| 대표 방제     | 補中益氣湯                                                   |
| 현대 의학적 고찰 | 내장하수(위하수, 신하수, 자궁하수, 탈항)<br>소화성 궤양, 소화계 기능문란, 하부 소화관 출혈 |

- ☑ 환자에게 꼭 물어야 할 것 “숨 차세요?” → 여기서의 숨 찬 것은 호흡곤란 아님!
- ☑ 기허환자는 근육수축력이 줄어든 상태이므로 횡격막이 충분히 내려가지 못해 숨이 참  
↳ 이것을 물어봐야 하는 것

## (3) 비양부진 脾陽不振

- ✓ 비기허가 진행된 것 → 腎陽까지 파급되면 뚜렷한 寒象을 나타냄
- ✓ 원인) 生冷, 肥甘物을 과식하거나 寒涼藥物의 과용, 久病에 의한 調養失調로 脾陽이 손상되어 발생함

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| 주증 | 形寒肢冷, 腹痛喜按, 瀉下清稀, 喜吐清水, 舌體胖, 邊有齒痕.         |
| 검증 | 面黃少華, 體倦懶言, 納呆便溏, 脛腹脹痛, 腹大水泛, 面浮肢腫, 脈沈遲而弱. |

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 임상특징      | 形寒肢冷                                                        |
| 치법        | 溫中健脾                                                        |
| 대표 방제     | 이중탕, 계강양위탕(인삼양위탕+계지, 건강)                                    |
| 현대 의학적 고찰 | 위장신경증, 만성위염, 위십이지장궤양, 위장기능문란, 만성 간염, 만성장결핵, 영양 불량성 수종, 만성이질 |

- ☑ 비양부진의 가장 두드러지는 특징 = “춥다고 함, 추위를 많이 탐”  
↳ 그렇다고 오한, 오풍까지는 아님
- ☑ 희안/거안으로 진단하기는 조금 어려움
- ☑ 설태의 경우 치료 시 일주일 사이로 변화가 빠르게 나타나므로 자세히 설진해야 함
- ☑ 맥진만으로 진단은 어려운 듯 함 (교수님피셜)

### ▶ 비기하함 VS 비양부진

- 공통점) 모두 비허로 脾失健運한 소치
- 차이점)
  - ① 비기하함: 비기허가 발전한 것 / 중기부족으로 인해 운화무력, 清氣不升하여 중기하함됨  
↳ 주요 특징) 寒象 없음! 오히려 발열 나타날 수 있음
  - ② 비양부진: 비위양기허약, 寒氣內生  
↳ 주요 특징) 虛寒象 있음! 발전하여 비신양허가 됨

### ▶ 내상발열

- 중기부족, 비기하함으로 인해 발생된 것
  - ① 비위의 원기가 부족하면 상화망동하여 병변이 발생함
  - ② 병기: 비위기허하면 下流于腎하여 陰火가 乘其土位함
  - ③ 치법: 補脾以治本, 瀉陰火以治標
  - ④ 방제: 보중익기탕
- 만성 편도선염, 폐결핵과 함께 소모성 질환 1등임!
- 우리 몸의 대사 소모가 빨리되어 피로가 많이 오는 질환 + 환자는 열감을 느낌

#### (4) 비허수증

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| 주증        | 四肢浮腫, 腹脹便澹, 肢倦神疲                            |
| 검증        | 全身浮腫, 胃脘滿悶, 納呆, 脘腹綿痛, 四肢厥冷, 舌質胖淡, 舌苔白潤, 脈濡緩 |
| 임상특징      | 脾主四肢 하니 脾處失健을 인한 四肢浮腫                       |
| 치법        | 健脾胃, 溫陽化水                                   |
| 대표 방제     | 實脾飲                                         |
| 현대 의학적 고찰 | 신장성 부종, 영양불량성 부종, 특발성 부종, 간경변 복수            |

- ☑ 몸이 붓고 피곤하며 만사 귀찮은 경우 + 속 더부룩, 음식 맛도 없음
- ☑ 실비음의 구성 약재 잘 알아두기  
↳ 백출, 복령, 대복피, 목고, 박하, 초과, 숙부자, 목향, 건강, 감초, 생강, 대조

#### (5) 비불통혈 脾不統血

- ✓ 비기허, 비기하함, 비양허의 증후와 함께 나타나는 출혈증
- ✓ 기의 고섭작용의 감약으로 발생하므로 氣不攝血 이라고도 함
- ✓ 혈관벽 평활근의 이완, 혈소판 무력증, 혈소판 감소, prothrombin 감소 및 기타 혈액 응고 인자의 결핍에 의한 출혈이라고 생각됨

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 주증        | 便血, 尿血, 嘔血, 肌衄, 崩漏                                          |
| 검증        | 面色蒼白, 倦怠, 納呆, 舌淡紅, 苔白, 脈細.                                  |
| 임상특징      | 비허로 인한 통혈기능의 감약으로 유발되는 각종 출혈                                |
| 치법        | 健脾攝血                                                        |
| 대표 방제     | 귀비탕                                                         |
| 현대 의학적 고찰 | 혈소판 감소성 자반병, 과민성 자반, 월경과다, 기능성 자궁출혈, 혈우병, 잇몸출혈, 재생 불량성 빈혈 등 |

- ☑ 소화기병으로 입원해있는 사람 중 알 수 없는 멍든 사람 많음
- ☑ 침 놓은 자리가 아닌데도 멍이 들어있는 경우 비불통혈의 경우라고 볼 수 있음
- ☑ 귀비탕 약재: 당귀, 용안육, 산조인, 원지, 인삼, 황기, 백출, 백복령, 목향, 감초

#### (6) 비음허 脾陰虛

- ✓ <<영추-본신>>: “脾藏營” 이라고 함
- ✓ <<사언거요-맥결>>: “營者陰血” 이라고 함  
↳ 脾營 = 脾陰
- ✓ 營: 음중지양으로 혈액 속에 존재 + 음혈과 같이 혈액 안을 운행함  
↳ 위기와 상대하면 음에 속하고 혈액고 상대하면 음에 속함
- ✓ 脾陰: 기혈의 사이에 끼어있고, 음양의 이중성을 구비하고 있음  
∴ 脾陰虧損은 단순히 음허가 아니라 陰氣俱虛임!  
+) 운화/승청 기능이 실조해도 음허 현상이 나타날 수 있음

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 주증    | 食少納呆, 或食後腹脹而喜按, 倦怠乏力, 形體消瘦, 脣色或淡或黃                                  |
| 검증    | 皮膚乾燥, 面色淡白或萎黃, 煩滿, 手足煩熱, 口乾不欲飲, 大便乾結或不爽, 舌淡紅少津, 苔薄, 脈濡而微數           |
| 임상특징  | 비음허와 비기허는 임상에서 함께 나타나는 경우가 많음<br>보기건비 or 溫運中陽을 효과 없거나 도리어 심해지면 비음허! |
| 치법    | 甘平濡潤, 扶脾養陰                                                          |
| 대표 방제 | 益脾湯, 滋脾飲, 養真湯                                                       |

### 2) 실증

#### (1) 한습곤비 寒濕困脾

- ✓ 습사로 인해 비위의 운화기능이 실조된 것
- ✓ 급성으로 오는 수분대사 장애, 위장기능장애를 말함
- ✓ 원인) 청량음료 과다섭취 / 과식, 생냉물 과식 / 다습환경 / 비에 장시간 젖는 등

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 주증        | 脘悶口粘, 頭身重困, 肢體浮腫, 舌苔白厚膩                                   |
| 검증        | 面色暗晦發黃, 飲食不香, 泛惡嘔吐, 大便溏稀, 脘腹脹滿, 脈濡細                       |
| 임상특징      | 納少便澹 (비기허약이 발전되면 비기하함이 됨)<br>비장의 수습운화 기능의 감약으로 발생하므로 水濕停滯 |
| 치법        | 補氣健脾                                                      |
| 대표 방제     | 藜苓白朮散, 四君子湯                                               |
| 현대 의학적 고찰 | 만성 위염, 만성 장염, 만성 이질, 만성 신염, 만성 간염, 수종                     |

- ☑ 다습한 환경 ex) 동남아 여행 갔을 때 등 많이 나타남
- ☑ 설사 환자가 오게 되었을 때 진단이 조금 어렵다면 첫 번째로 위령탕을 고려함



## (2) 습열상비 濕熱傷脾

- ✓ 습열사에 의한 것으로 습곤비위 증후와 함께 열증이 나타나는 것이 특징
- ✓ 위장장애, 수분대사 장애에 염증이 수반되는 것
- ✓ 원인) 열사의 감염, 지방분이 많은 음식 혹은 미식의 과다섭취, 주독 등

|           |                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------|
| 주증        | 脘脇脹痛，面目身黃如橘，小便短赤，苔黃厚膩                              |
| 검증        | 納呆，惡油，惡心嘔吐，口乾而苦，便秘，身重肢困，皮膚瘡瘍，濕疹流黃水，大便色淡粘臭，口渴發熱，脈濡數 |
| 임상특징      | 濕熱互結로 인해 비색이 外現하므로 身黃如橘이 특징                        |
| 치법        | 清熱利濕退黃                                             |
| 대표 방제     | 加味茵陳蒿湯                                             |
| 현대 의학적 고찰 | 급성 황달성 간염, 급성 담낭염, 담결석, 膿疱瘡, 습진, 급성장염              |

- ☑ 급성 간염에 나타나는 간질환으로 황달이 주 증상!
- ☑ 간혹 발진, 피부 알러지 환자에게 인진호탕을 쓰면 잘 들었음  
↳ 피부 알러지가 간의 대사가 잘 안되는 것에 영향이 있나? 하는 교수님의 말씀..

## 2. 위병

### 1) 위허증

#### (1) 위기허 胃氣虛

- ✓ 위양기가 부족한 것
- ✓ 위의 연동운동 감약, 순환불량, 留飲 등에 의한 증후

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 주증        | 胃脘痞滿，食後不化                    |
| 검증        | 不思飲食，時作噯氣，大便不賈，舌淡苔少，脈細弱      |
| 임상특징      | 위의 납곡기능의 감약으로 발생하므로 식후의 胃脘脹滿 |
| 치법        | 益氣健中                         |
| 대표 방제     | 升陽益胃湯                        |
| 현대 의학적 고찰 | 만성 위염, 소화불량, 위십이지장궤양, 病後체약 등 |

- ☑ 혈액순환가 연동운동이 잘 안되어 더부룩한 느낌이 있음 + 밥만 먹으면 속이 불편해짐

## (2) 위음허 胃陰虛

- ✓ 위의 진액부족에 의한 것
- ✓ 소화관 전반, 특히 위점막의 분비 부족, 점막의 위축, 만성염증 등으로 인해 일어남

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| 주증        | 胃脘嘈灼疼痛，口乾舌燥，舌絳無苔               |
| 검증        | 胃脘部痞滿疼痛，似飢而不欲食，虛煩，噯氣乾嘔，脈細數     |
| 임상특징      | 위음이 부족하고 진액이 상승하지 못하므로 口乾，舌紅無苔 |
| 치법        | 滋陰養胃                           |
| 대표 방제     | 養胃湯                            |
| 현대 의학적 고찰 | 만성위염, 위신경증, 소화불량               |

- ☑ 항생제 등과 같은 양약을 먹고 나타날 수 있는 증상
- ☑ 양위탕: 사삼, 옥죽, 천화분, 상엽, 맥문동, 생편두, 생감초

### 2) 위한증

- ✓ 보통 위허증과 병존하며 위양기가 부족한 것
- ✓ 위의 연동운동 감약, 순환불량, 留飲 등에 의한 증후
- ✓ 원인) 부절제, 생냉물의 과식, 정신적 스트레스에 의해 위양기가 손상되어 발생

|           |                                                                                    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 주증        | 胃痛綿綿，泛吐清水，苔白滑                                                                      |
| 검증        | 噯逆嘔吐，反酸噯氣，食後胃痛緩解，甚則胃脘拘急劇痛，四肢不溫，脈沈遲而弦                                               |
| 임상특징      | 喜食熱物，得熱則減，遇冷則甚                                                                     |
| 치법        | 溫胃散寒，降逆止嘔                                                                          |
| 대표 방제     | 厚朴溫中湯                                                                              |
| 현대 의학적 고찰 | 부교감 신경의 우세로 인한 위장기능 문안으로 위장평활근 경련, 위산분비증가, 위배출시간의 증가 등이 나타남<br>潰瘍病과 그 합병으로 인한 幽門硬塞 |

- ☑ 혈액순환가 연동운동이 잘 안되어 더부룩한 느낌이 있음 + 밥만 먹으면 속이 불편해짐

### 3) 위열증

- ✓ 胃火가 오래되어 진액이 소모된 소치

#### (1) 위중허열 胃中虛熱

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 주증        | 口乾舌燥, 煩熱不安, 食後易飢, 舌紅而乾                                       |
| 검증        | 胃痛隱隱, 吐血, 衄血, 嘈雜, 口渴, 大便乾, 脈細數.                              |
| 임상특징      | 위음허를 거친 것으로 煩熱不安이 특징                                         |
| 치법        | 清熱益陰                                                         |
| 대표 방제     | 玉女煎                                                          |
| 현대 의학적 고찰 | 내분비 이상으로 인한 대사문란으로 소모량과 수요량이 증대된 소치로서 당뇨병, 전염병 후기 등에서 볼 수 있다 |

#### (2) 위중실열 胃中實熱

- ✓ 위양이 강한데, 여기에 정서적 火가 어우러지거나 외사가 入裏化熱하거나 辛辣厚味를 과식하여 위중에 열이 축적된 것

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 주증        | 胃脘灼痛, 口渴喜飲, 嘈雜易飢, 舌紅少津               |
| 검증        | 食入則吐, 牙齦腫痛, 出血, 口臭泛酸, 脈細滑數           |
| 임상특징      | 발병이 급하고 喜冷惡熱이 특징                     |
| 치법        | 清胃瀉火                                 |
| 대표 방제     | 清胃散                                  |
| 현대 의학적 고찰 | 세균 or 기타요인으로 인한 급성위염, 구강염, 치주염, 치통 등 |

### 4) 위실증

#### (1) 위완식적 胃脘食積 (=비허협식)

- ✓ 본래 비위가 허약해 일상의 음식으로 실체가 발생한 것

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 주증        | 脘腹脹滿, 納呆胃痛, 舌苔厚膩              |
| 검증        | 惡心嘔吐, 口臭噯腐, 大便不爽, 脈滑          |
| 임상특징      | 胃主納穀의 실조로 인한 것으로 脘腹脹滿, 拒按이 특징 |
| 치법        | 消食導滯                          |
| 대표 방제     | 保化丸                           |
| 현대 의학적 고찰 | 급성 소화불량, 급성위염                 |

#### (2) 열결위부 熱結胃腑

- ✓ 외감열병으로 인한 양명열성의 소치

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 주증        | 身熱口渴, 胃脘脹滿, 腹痛拒按, 大便不爽, 苔黃燥, 脈洪大 |
| 검증        | 尿赤, 口乾, 口臭, 心煩, 納呆               |
| 임상특징      | 痞滿實熱                             |
| 치법        | 清熱瀉結                             |
| 대표 방제     | 調胃承氣湯                            |
| 현대 의학적 고찰 | 감염성 질병의 중기에 나타나기 쉬움              |

#### (2) 어혈정위 瘀血停胃

- ✓ 기체가 오래되어 혈어가 생기고, 혈어가 오래되어 胃絡을 상하며, 絡脈이 손상되어 血이 밖으로 흘러나온 것

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 주증        | 胃脘刺痛, 痛有定處, 拒按                     |
| 검증        | 吐血色紫黑, 大便如柏油狀, 食後痛劇, 舌暗紅有形斑, 脈細澀   |
| 임상특징      | 胃脘 刺痛拒按                            |
| 치법        | 活血化瘀, 理氣止痛                         |
| 대표 방제     | 加味丹蔘飲                              |
| 현대 의학적 고찰 | 위십이지장궤양 출혈, 자극성반사성 궤양출혈, 만성위염합병 출혈 |

- ☑ 자통이 일정한 부위에 나타나는 것이 특징

※ 소장병은 꼭 읽어봐라 라고 하시고 넘어가셨습니다 (중요도가 낮아보이네요)

### 3. 소장병

#### 1) 실열증

- ① 주증: 구설생창, 소변삽통
- ② 겸증: 심번구갈, 인통耳聾, 소복작창, 경중삽통, 뇨혈, 설홍태황, 맥활삭
- ③ 임상특징: 心火熾盛의 증상과 종종 겸하여 나타남
- ④ 치법: 清利실열
- ⑤ 대표처방: 導赤散

#### 2) 허한증

- ① 주증: 소복은통희안, 소변빈삭불상
- ② 겸증: 장명설사, 희온오한, 설염태백, 맥세완
- ③ 임상특징: 비신양허와 종종 같이 나타남
- ④ 치법: 온보소장, 산한지통
- ⑤ 대표처방: 오수유탕가육두구
- ⑥ 현대 의학적 고찰: 비위기능 실조 범위에 속함

#### 3) 소장기동

✓ 한체간맥증으로 개괄되어지는데, 한실증에 속하며, 산기와 장경련증에서 나타남

- ① 주증: 소복구급동통,련내요척,하공역환
- ② 겸증: 역환중대,소복견만,복창장명,태백,맥침세
- ③ 임상특징: 소복급통이 파급되는 부위는 일정하지 않음
- ④ 치법: 행기산결지통
- ⑤ 대표처방: 굴핵환
- ⑥ 현대 의학적 고찰: 산기, 장경련

### 4. 대장병

#### 1) 한증

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| 주증        | 腹痛腸鳴,綿痛喜按,大便溏瀉      |
| 겸증        | 四肢不溫,小便清白,舌苔白滑,脈後沈弱 |
| 임상특징      | 得熱則緩,遇冷則甚           |
| 치법        | 溫腸散寒止瀉              |
| 대표 방제     | 附子理中湯加肉荳蔻           |
| 현대 의학적 고찰 | 만성이질, 만성장염, 장결핵 등   |

#### 2) 열증

##### (1) 대장열결 大腸熱結

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 주증        | 痔瘡,大便祕結,肛門灼熱腫痛        |
| 겸증        | 大便腐臭,使後帶血,小便短赤,苔黃燥,脈數 |
| 임상특징      | 肛門 腫痛                 |
| 치법        | 清熱瀉結,化淤止血             |
| 대표 방제     | 槐角丸                   |
| 현대 의학적 고찰 | 장티프스 초기, 급성 장폐색증, 복막염 |

##### (2) 대장습열 大腸濕熱

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| 주증, 임상특징  | 下痢膿血                     |
| 겸증        | 發熱身重,腹痛,裏急後重,舌苔黃膩,脈滑數    |
| 치법        | 清熱化濕                     |
| 대표 방제     | 白頭翁湯                     |
| 현대 의학적 고찰 | 급성 세균성 이질, 아메바성 이질, 급성장염 |

#### 3) 허증

##### (1) 대장진후 大腸津虧

- ✓ 폐허로 기와 津이 숙강하지 못하거나 신음부족으로 대장을 윤택하지 못해 초래됨
- ✓ 이후 전도 기능 저하되고 대변이 건결됨

|    |                        |
|----|------------------------|
| 주증 | 大便乾燥 不易排出              |
| 겸증 | 頭昏神疲 形體消瘦 口乾咽燥 舌紅苔少脈細弱 |

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 임상특징      | 대변조결, 腹無脹痛        |
| 치법        | 增液潤腸, 益肺生津        |
| 대표 방제     | 黃芪湯加何首烏           |
| 현대 의학적 고찰 | 만성이질, 만성장염, 장결핵 등 |

☑ 노인성 변비가 여기에 해당하는 경우가 많음

☑ 대변이 매우 딱딱하고 화장실을 잘 못가는데, 복진 시 눌러도 환자가 통증을 느끼지 않음

## (2) 대장불고 大腸不固

- ✓ 오랜 병이 二便을 담당하는 腎에 영향을 주어 비신이 모두 허해지고, 대장이 견고하지 못하게 되면 久痢, 久瀉이 발생하고 심하면 대변이 滑脫失禁함
- ✓ 비가 허하여 기가 아래로 처지면 항문이 빠지며 부어오르고, 심하면 탈항됨
- ✓ 이때 복통이 喜溫喜按하면 대장허한의 증상임

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 주증        | 久瀉 久痢 肛門墮脹 滑脫失禁                   |
| 검증        | 面色無華, 便后脫肛腹中隱痛, 喜溫喜按, 舌質淡白, 脈沈遲而弱 |
| 임상특징      | 사리가 오래되어 낫지 않음                    |
| 치법        | 溫補脾腎, 澁腸固脫                        |
| 대표 방제     | 真人養臟湯 (+ 계강양위탕)                   |
| 현대 의학적 고찰 | 만성이질, 만성장염, 궤양성결장염 등              |

☑ 오래된 설사증으로 과민성 장 증후군이 매우 오래된 경우에 해당

## 4) 실증

- ✓ 폐장移 열於大장으로 인한 것
- ✓ 발열 시 인체의 수분 수요량 증가되고, 대장 연동운동이 감약되며, 대장의 수분흡수가 증가되어 대변비결에 이른 것
- ✓ 조시가 체내에 장시간 정류되어 있어 전신증상과 소화계통의 증상 나타남

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 주증        | 腹痛拒按, 大便燥結                   |
| 검증        | 腹部脹滿 發熱嘔逆 潮熱譫語 小便短赤 舌苔黃燥 脈沈實 |
| 임상특징      | 痞, 滿, 燥, 實, 堅 모두 구비함         |
| 치법        | 通瀉實熱                         |
| 대표 방제     | 大承氣湯                         |
| 현대 의학적 고찰 | 급성 장 폐색증, 복막염 등              |

## 5. 타 장기와의 관계

☑ 비는 중앙 토 이므로 타 장기와 밀접한 관계를 가지고 있음

### 1) 心 - 心脾兩虛 심비양허

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 원인    | 사려, 노권으로 심비를 상하게 하여 오래되면 심비가 모두 허해짐                                |
| 주증    | 心悸(가슴이 두근거리고) 少寐(잠이 적으며) 倦怠納呆(몸이 나른하고) 식욕 없으며 腹脹便溏(배가 부어오르고 변이 묽음) |
| 검증    | 面色萎黃, 身浮腫, 頭昏頭暈, 月經量少色淡, 舌質淡紅苔白, 脈虛緩                               |
| 치법    | 健脾養心定神定志                                                           |
| 치방    | 歸脾湯                                                                |
| 관련 질환 | 신경쇠약, 갱년기 증후군, 만성위장염, 빈혈                                           |

☑ 정신적 stress나 노력들이 소화기 증상에 미치는 영향이 매우 중대함

### 2) 腎 - 脾腎陽虛 비신양허

#### (1) 양허수범 陽虛水泛

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 주증    | 全身浮腫 腰以下尤甚                 |
| 검증    | 腹脹便溏, 形寒肢冷, 面色萎黃 腰膝冷痛 小便短少 |
| 치법    | 溫腎健脾                       |
| 대표 방제 | 眞武湯                        |
| 관련 질환 | 만성 신염, 폐심병, 심장성 수종, 간경화 복수 |

#### (2) 오경사 五更瀉

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 주증    | 鷄鳴時 臍下作痛 腹鳴即瀉                                   |
| 검증    | 腹中冷痛喜按, 少氣, 神疲, 浮肢腫, 畏寒肢冷, 小便短少, 舌質淡嫩, 苔白潤, 脈沈細 |
| 치법    | 溫補脾腎, 澁腸止瀉                                      |
| 대표 방제 | 四神丸 + 附子, 烏梅                                    |
| 관련 질환 | 만성 결장염, 과민성 결장염                                 |

## 3) 肝

## (1) 肝脾不和 간비불화

|    |                                              |       |      |
|----|----------------------------------------------|-------|------|
| 주증 | 脇腹脹痛 腹瀉腸鳴 瀉必腹痛                               |       |      |
| 검증 | 噯氣, 吐酸, 易怒, 遇怒者證加劇, 納呆, 食入不化, 脘腹脹滿, 舌紅白苔, 脈弦 |       |      |
| 치법 | 瀉肝補脾                                         | 대표 방제 | 痛瀉要方 |

## (2) 肝胃不和 간위불화

|       |                                  |       |                    |
|-------|----------------------------------|-------|--------------------|
| 주증    | 胃脘痞滿 胃脘脹痛連及兩脇, 納呆, 易怒            |       |                    |
| 검증    | 泛吐酸水 惡心嘔吐 舌質紅少苔 脈弦               |       |                    |
| 치법    | 抑肝和胃                             | 대표 방제 | 四逆散 + 대자석, 청반하, 불수 |
| 관련 질환 | 만성 간염, 만성 담낭염, 담결석, 늑간신경통, 위장신경증 |       |                    |

## (3) 膽胃不和 담위불화

|       |                                    |       |     |
|-------|------------------------------------|-------|-----|
| 주증    | 홍창통, 위열구고 (옆구리 붓고 아프며 위가 뜨겁고 입이 씹) |       |     |
| 검증    | 오심구토, 토산, 위통거안, 노적변비, 설태항니, 맥상현삭   |       |     |
| 치법    | 辛開苦降, 瀉膽安胃                         | 대표 방제 | 左金丸 |
| 관련 질환 | 급만성 담낭염, 만성 비후성위염                  |       |     |

## (4) 肝胃血瘀 간위혈어

|       |                                               |       |       |
|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|
| 주증    | 兩脇積聚, 肌膚甲錯, 腹大如鼓, 青筋暴露, 嘔吐, 便血如漆              |       |       |
| 검증    | 上半身有蟹爪紋路, 面浮肢腫, 小便短少, 飲食減少, 大便不實, 舌質紅有瘀斑, 脈沈澁 |       |       |
| 치법    | 소간이기, 활혈화어                                    | 대표 방제 | 膈下逐瘀湯 |
| 관련 질환 | 간경화 복수, 간암 후기                                 |       |       |

## (5) 肝脾兩虛 간비량허

|       |                                                   |  |  |
|-------|---------------------------------------------------|--|--|
| 주증    | 納呆, 便溏, 眩暈, 筋脈拘急                                  |  |  |
| 검증    | 脘腹脹滿, 四肢乏力, 面色萎黃, 兩目昏花, 月經量少色淡, 舌體胖質淡 邊有齒印, 脈弦細而緩 |  |  |
| 치법    | 逍遙散                                               |  |  |
| 관련 질환 | 만성위염, 만성장염, 만성이질, 위십이지장궤양                         |  |  |

## 비계내과 3주차 SUMMARY

## 내상 內傷

## 1. 음식상 飮食傷

## 1) 원인

- ① 飮食失常: 음식실상과 식생활 습관의 실상 (과식, 기식, 기아, 불규칙한 식사 등)  
# 기아: 이제는 거의 없다고 볼 수는 있으나, 혼자 사는 노인분들 잘 챙겨먹지 못하는 경우에 해당  
↳ 식생활은 직접적으로 소화기에 영향을 미치는 요인!
- ② 飮食偏嗜: 음식의 내용이 편중되거나 과냉/과열한 음식을 습관적으로 먹는 것  
- 자극성 음식, 생냉물, 술, **고량후미** 요새는 인스턴트와 칼로리적으로 과잉 영양되는 것이 더 문제..
- ③ 飮食不潔: 음식불결 - 오염된 음식, 부패음식, 기생충, 오염물질, 독성물질 등  
# 요새는 합성된 건강기능식품(=독성물질일수도..) 유익 + 위생상태 양호한 음식 먹기
- ④ 약물에 의한 장애 - 약물 과잉 등

## 2) 증상

| 주증                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>위완부 흉벽이 막히고 답답함 / 썩은 내 나는 트름 / 속 더부룩하고 미식거림</li> <li>음식을 먹지 못하고 신물이 올라옴 / 설사를 하거나 냄새나는 방귀를 뀌</li> <li><b>左手關脈平和 右手關脈緊盛</b> 좌관맥은 정상인데 우관맥은 긴성하다.<br/>↳ a) 우관맥만 긴맥이면 = 소화기 자체의 질병 (평위산류 사용)<br/>b) 좌관맥까지 간다면 = 타 장기에 의해 영향을 받음 - stress 간기울결 (통사요방, 사역산 등 사용)</li> </ul> |
| 검증                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>頭痛身熱, <b>但身不痛</b>爲異耳, 흑복통토사, 중즉발열두통</li> <li><b>但身不痛</b>: 내상과 외감을 구별하는 구별점</li> </ul> <p># 체한 경우 자율신경계가 제대로 작동하지 않아 복부의 증상이 나타나기 전에 전신적 증상 (두통, 어지럼증, 무력감 등)이 나타남</p>                                                                                                  |

### 각종 원인에 따른 증상

- 고량후미: 암 발생과 관련 多
- 독성 음식: 술, 부패된 음식(냉동식품 유의)
- 기생충, 과식열물, 오미편식 등

### 3) 치법

- ☑ 체하면 ① 음식의 양을 줄임 ② 소도 ③ 공하, 토하
- ☑ 음식물 정체, 기 손상O: 보익 + 소도
- ☑ 음식물 정체, 기 손상X: only 소도
- ☑ 비위를 보하는데 심경약이 필요한데 이때 익지인을 많이 가미함
- ☑ 차가운 것에 상했을 때에 반하 신곡 건강 삼릉 봉출 백출을 씀

#### 삼릉과 봉출

- 다량을 쓸 경우 파기/파어혈제로 기울 or 기체를 풀어주는 역할을 함
- 용량을 적게 쓸 경우(2-3g)엔 간담의 소화작용에 영향 O
  - ↳ 간기울결, 간기범위, 간비불화에 쓰는 처방에 많이 들어감
- 특히 50대 이상의 노인분들에게 다용

### 4) 치방

#### ① 消導소도지제

- 지출환: 지출(소도, 제담) + 백출(건비) = 보익, 소도의 대표처방  
단독으로보단 다른 처방에 가미를 많이 함
- 평위산, 향사평위산, 내소산, 소체환 등 교수님께서 언급하신 것만 적어드렸습니다!

#### ② 補益보익지제

- 노인, 소아, 평소에 위장이 약한 人
- 사군자탕, 전씨이공산, 향사육군자탕, 삼출건비탕, 보중익기탕

## 2. 주상 酒傷

### 1) 원인

- ☑ 음주과다, 폭음주

### 2) 증상

- ☑ 숙취 등으로 나타나는 증상으로 볼 수 있음
- ☑ 눈이 잘 안 보임 / 정신없음 / 갈증남 / 뇨적 / 사지 힘빠짐 / 오심구토 / 손발떨림

### 3) 치법

- ☑ 발산한출, 리소변

#### ☞ 향이뇨호르몬과 술

- 적당히 먹으면 소변량이 늘지만, 블랙아웃 상태까지 마시게 되면 향이뇨호르몬이 나와 소변을 오히려 못 보게 됨

### 4) 치방

- ☑ 갈화해성탕, 주증황련환, 신선불취단
- ☑ 보통 주상으로 오는 질환은 급성질환이므로 드물
- ☑ 간수치가 높거나 간경화로 인해 내원하여 약을 달라고 하는 경우 多

#### ☞ 곡달 穀疸

- 증상: 한열이 있고 음식을 먹지 못함 / 두현, 심중불안, 복부창만  
↳ 오래되면 發黃
- 원인: 위중에 열이 있거나 대식 후에 과식하여 정체되어 발생
- 치법: 소온중환, 소달건비탕★

#### ☞ 소달건비탕 消疸健脾湯 ★

- 주증: 諸疸을 통치하며 곡달로 음식이 소화되지 않으며 불능음식하며 번심하고 흉복창만 하는 증상에 씀
- 소화불량, 가슴답답, 기능성 소화불량증 양상 + 간기울결 간기범위 우울증 화병 (비계내과에서 가장 많이 쓰이는 보비탕 다음으로 많이 쓰는 처방임)
- 향부자 인진 산사육 창출 백출 박하 진피 저령 택사 적복령 산치자 나복자 곽향 반하 삼릉 봉출 청피 대복피 감초
- 간담습열증에도 많이 쓰고 역류성 식도염에 가감해서 쓴다.



### 간담습열방 ★

- 알코올성 간염, 간경화, 간수치 많이 높은 환자들에게 씀 - with 가미
- 거의 대부분 이걸 쓰면 간수치가 잘 떨어짐
- 갈화 인진 지구자 백출 택사 갈근 진피 황련 저령 대복피 후박 사인 곽향 초두구 목랑 감초 봉출 삼릉

### 소달건비탕가미방 사용 환자 Case

- 환자: 간경화 진단 + 주류도매업 + 흡연, 음주 多
- 주증: 소화불량, 피로, 피부트러블 = 간의 대사가 잘 안되는 것
- 치료: 소달건비탕 + 녹용 + 금연, 금주
- 예후: 1년 정도 치료 후 호전됨

## 5) 음주금기증

- ☑ 세잔 이상 먹지 마라
- ☑ 너무 빠르게 마실 경우 폐가 상하게 됨 (급하게 먹지 말기)

+ 구토를 심하게 할 경우 손발이 떨리고 경직되는 tetany 생길 수도 있음

## 3. 노권상 勞倦傷

- 육체적 정신적 과로에 의해 발생하는 내상병의 일종
- 피로, 권태감, 무기력, 불안, 초조 등을 호소
- 운동부족으로 발생하는 질병은 기혈의 운행장애로 원기부족의 증상을 나타냄

### 1) 원인

- ① 노력상 過力傷: 육체적 피로 과다로 인한 원기허손
- ② 노심상 勞心傷: 사려과다로 인한 기혈허손 ex) 수험생 등
- ③ 방로상 房勞傷: 방로 과다로 인한 정기소모  
# 맨날 피곤하다고 하는 학생: 거의 매일 자위하여 피곤하게 된 것.. → 운동시키면 됨
- ④ 일병 逸病(과일상): 너무 안 움직여서 기혈운행불창

### 2) 병리

- ☑ 형기쇠소, 곡기불성, 상초불행, 하완불통
- ☑ 음허내열 = 허열이 뜬다 (하지만 말씀하시고 획 지나가심)

### 3) 증상

- ① 주증: 미열이 남 / 움직이기 싫음 / 말하기 귀찮음 / 열감 / 심번불안
- ② 겸증: 불면 / 입맛X / 만사 귀찮 / 자꾸 눕고 싶음 / 사지 힘 X / 구갈 / 어지러움  
# 만성 피로 환자에게 모두 물어봐야 함. 거의 다 해당할 것. 다 알아두자.

### 4) 치법

- ☑ 溫하게 함 = 조기음식(음식을 고르게 하고), 기거를 알맞게 하며, 마음을 맑게 하여 조용하게 진기가 저절로 회복되도록 한다.

### 5) 처방

- ① 노력상 過力傷
  - 보중익기탕: 노력과도로 인해 비위허약, 중기부족일 때 보중익기탕을 씀
  - 황기건중탕: 노심초사하여 혈이 손상되고 땀이 날 때 씀
  - 쌍화탕: 심신의 과로로 인해 기혈이 손상되었을 때 씀
- ② 노심상 勞心傷: 당귀보혈탕, 귀비탕(허증), 온담탕(실증), 소요탕
- ③ 방로상 房勞傷: 육미, 자음강화탕, 쌍화탕
- ④ 일병 逸病(과일상): 보중익기탕, 삼출탕, 승양보기탕 - but 운동시키는 것이 근본치료

#### 4. 식후혼곤 食後昏困

- 밥만 먹으면 졸린 것
- 증상: 음식이 들어가면 노곤하고 정신이 혼미한데 이는 비위가 허약하기 때문
- 춘곤증이랑은 조금 다른 남자들 갱년기 “밥만 먹으면 졸리다고 함”
- 처방: 삼출탕, 보중익기탕 등

#### 5. 불사식, 불기식 不思食, 不嗜食

식욕부진 part에서 다룰 것

#### 6. 내상병의 열증과 한증 (中 = 傷)

- ① 열증: 내상병 초기에 열사에 상한 것처럼 열증이 나타나는 것  
= 내상발열, 허열이 나는 것  
- 처방: 보중익기탕, 익위승양탕 등
- ② 한증: 내상병 중국에 한사에 상한 것처럼 한증에 나타나는 것  
= 비위허한증, 대장한증 등이 나타남  
- 처방: 침향온위환, 백출부자탕 등

#### 7. 불복수토병 不伏水土病

- 풍토병: 우리나라에서는 보기 힘들. 캄보디아, 네팔 등에서 볼 수 있음
- 처방: 곽향정기산, 평위산, 불환금정기산

#### 8. 식궤 食厥

- 폭음폭식으로 인한 인사불성
- 薑鹽湯으로 토법 후 加味六君子湯 + 119 부르고 응급처치
- 고혈압 환자들이 급하게 먹었을 때 해당되지 않을까.. (보기 드뭄)

##### 교수님의 베트남 출장 썰

- 호텔에서 연잎밥 같은 것을 먹고 이후 오한 발열 하루 20번 설사
- 심선혈, 팔사풍 했는데도 안 낫고 죽겠음
- 새벽에 땀이 나서 푸쉬엄하며 땀을 매우매우 냄
- 이후 오한 발열이 조금 낫고 살만해짐 + 하루 15번씩 설사하며 의료봉사 버팀

#### 9. 식적류상한 食積類傷寒

- 상한과 증상이 유사한 것

- ① 원인: 傷食成積
- ② 증상: 두통, 발열, 오한하는 것이 완전히 상한과 유사하나 다만 몸이 아프지 않고 심복이 포만하여 애, 천, 구역하고 촌맥이 현성한 것이 상한과 다름  
# 체육대회에서 찬 것 먹고 생길 수도 있음

##### 교수님의 MI 환자 썰

- 40대 초중반 체육대회를 하다 체해서 침 맞으러 온 남성 환자
- 체육대회에서 열심히 땀 후 수박, 차가운 맥주 등을 먹고 체한 것 같다고 함
- 침을 놓으려다가 뭔가 이상해서 전북대 병원으로 보냄
- 20분 뒤 보호자가 전화와서 환자가 심혈관질환으로 중환자실 갔다고 함 = MI였음
- MI의 티피컬한 증상이 위와 같이 안 나타날 수 있음 .. 조심 !

#### 10. 식역증 食飢證

- 잘 먹는 것 같으나 마름 / 쉽게 배고픔 / 肌膚를 生하지 못함
- 소화기능이 떨어져 있는 경우
- 처방: 삼령원

#### 11. 오미과상위병 五味過傷爲病

그냥 넘어가심 ..!

### 내상병의 조치

교수님께서 굉장히 빠르게 훑고 넘어가신 part! 언급하신 것만 넣어두겠습니다.

“ 식약근원, 안양심신 .. 쪽 읽어보시고 “

#### 1) 내상장리법 內傷將理法 설명하신 것만 넣었습니다

- 5번) 환자의 음식, 의복, 한온 등을 적절히 해야 한다.
- 8번) 고기를 삶아먹고 생으로 먹지 말아야 한다.
- 13번) 먹고 누우면 적체가 생긴다. but 위하수 환자는 식후에 누우면 도움이 된다고 하기도 함
- 14번) 밤에 많이 먹거나 술 많이 먹지 말아야 한다.

# 비계내과 4주차 SUMMARY

## 기능성 위장장애

### 개요

#### ✓ 기능성 위장장애란?

현재 우리가 시행할 수 있는 어떠한 검사법으로도 기질성 병변이 발견되지 않는데도 환자가 소화기 계통의 증상을 나타내는 임상 증후군

- 구조적 또는 생화학적 이상으로는 설명되지 않는 만성/재발성의 다양한 위장관 증상들의 조합으로 특징 지워짐
- 원인불명의 흉통(비심장성 흉통), 비궤양성 소화불량, 담도이상운동증(오디팔락근 기능장애) 등의 여러 가지 임상상들이 이러한 광범위한 증후군에 포함됨

# 흉통: 심장성 흉통, 비심장성 흉통, 식도성 흉통(역류성 식도염)의 감별이 중요함

- 확진의 과정이나 검사법 존재 X
- 적합한 임상양상의 존재여부와 다른 기질적 질환의 배제를 기초로 한 다소 주관적 진단이 이루어짐
- 기질성 질환에서도 기능장애를 일으키는 것은 당연하지만, 다만 기능성 질환은 기질성 질환이 없으면서 기능장애를 일으키는 경우만을 가리킴

↳ 기능성 질환: 환자들의 혈액검사, 내시경 검사 결과에서 이상 소견 나오지 않은 경우

+ 환자들이 "저 원래 위장관이 좀 안 좋아요" 라고 하는 경우

#### ✓ 기능성 위장장애의 분류 - 상부/하부

##### 1) 상부 위장관 기능장애

- 구역, 구토, 트림, 속쓰림, 속쓰림, 식후 상복부 불쾌감, 공복 시 상복부 통증 등의 증상을 주로 나타내는 것
- 좁은 의미) 기능성 위장장애, 신경성 위장병, 신경성 위염
- 우리나라에서 압도적으로 발생빈도가 많음
- 비궤양성 소화불량증

2) 하부 위장관 기능장애 = 과민성 (대)장 증후군 = 신경성 설사 / 경련성 장염 / 점액성 장염 등

- 하복부 불쾌감, 동통, 복부 팽만감, 헛배부름, 우상복부 불쾌감, 복통, 변비, 설사 등의 증상을 주로 나타내는 것
- 서구에서 발생빈도 매우 높음
- 우리나라에서는 그렇게 흔하진 않았으나 최근 급격히 증가하고 있음

- 예전엔 신경성 설사로 표현했는데 지금은 과민성 장 증후군이라고 진단명이 정해짐
- 소화불량증 환자는 상복부의 불편한 증상을 호소하며 먼저 내원하지만, 과민성 장 증후군환자는 먼저 내원하지 않는 특징 있음
- 대부분 다른 질환으로 내원하였다가 문진 도중 과민성 대장증후군을 발견하는 경우가 많다.
- 이러한 환자들은 이미 본인의 대장 증상에 익숙해져 그동안 불편함을 느끼지 못하고 있었던 것!
  - ↳ 대부분 눈 뜨자마자 화장실 가고, 식전후에 설사가 모두 일어나 낮에 3-4회의 설사로 끝남
  - ↳ 야간에 설사하러 가는 경우는 드물고 배가 아픈 것은 설사를 하면 사라짐

※ 소화불량증: 음식 섭취 후 일어나는 소화장애뿐만 아니라 속쓰림, 트림, 구역질, 상복부 불쾌감, 팽만감, 고창 및 설사의 동반(소화흡수장애, 장운동이상)을 모두 포함

### 상부 위장관 기능장애

#### 1) 개요

- 식도 및 위의 순수기능장애는 아직 명확히 정립되지 않음
- 식도의 여러 운동장애는 대개 근육 or 신경의 이상이 증명되는 경우가 많음
- 위의 급만성 염증에 동반되는 기능장애는 그 염증과 관계가 있는 것인지 없는 것인지 분명하지 않을 때가 많음

#### 2) 주요 증상

- 구역, 구토, 식욕부진, 소화불량(식후 상복부 불쾌감), 신트림, 속쓰림, 공복통 등

#### 3) 발생 기전

- ① 위운동성의 저하, 위내용물의 배출기능 장애 등이 원인
- ② 급속위증<sup>급속위증</sup>, 불정속위<sup>부정속맥</sup> 등과 같은 위벽의 근전기 이상과 연관
- ③ 십이지장 내용물의 위내역류: 속쓰림이나 상복부 불쾌감의 원인

#### 4) 원인

- 불분명하지만, 정신적인 스트레스, 과식, 과음, 자극성 음식 등이 거론

- 보통 식사를 하게 되면 1시간 반~2시간 사이에 십이지장을 통해 위가 비워짐
- 소화불량이 있는 사람은 2시간 이상씩 위에 머물게 됨 (역류성 식도염을 동반할 수도 있음)
- ↳ 이런 환자에게는 오후 6시 이전에 밥을 먹고 3시간 이상 공복을 유지하라고 해야 함

## 5) 진단방법

- ① 위내시경 검사: 정상
- ② 위 X선 투시 및 촬영검사: 정상
- ③ 초음파 검사: 담낭, 담도, 간, 췌장 모두 정상이어야 함
- ④ 위내용물 배출시간 검사: 정상일 수 있으나 다소 감소되어 있는 경우 다
- ⑤ 위장관 운동성 검사: 위 및 십이지장의 운동성이 다소 감소된 경우 다
- ⑥ 위산분비 검사: 다소 증가해 있는 경우 다
- ⑦ 간기능 검사, 소변 검사 등: 모두 정상

## 6) 감별진단 - 기질적 변화가 있는 질환과 감별해야 함

- 위궤양, 십이지장궤양 / 위암 / 역류성 식도염 / 만성 간질환 / 만성 췌장염
- ↳ 최근 역류성 식도염 환자가 늘어남에 따라 증상과 질환 감별이 필요해짐

### ☞ 산사 신국 맥아의 작용

- ① 위운동성 저하로 음식물이 위에 오래 있을 때 위 평활근 운동을 강화/촉진해 소화력을 좋게 한다.
- ② 소화액의 분비를 촉진시킨다.
  - ↳ 십이지장 내용물의 위내역류 or 역류성 식도질환에 가장 많이 쓰는 약
  - = ppl = 위산 분비를 억제해줌
  - ↳ ppl의 역할과 산사/신국/맥아의 작용이 상반됨 → 그럼 산/신/맥 쓰면 안되나요?
  - A) 써도 된다. 그냥 약물의 용량을 작게 조절하면 됨!

## 7) 치료

### (1) 약물요법 그냥 속 넘어가심

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ① 위장관운동 촉진제 | 식후 상복부 불쾌감, 팽만감이 심한 환자<br>위장관 운동이 저하되어 있으므로 운동성 증강시키는 약 사용 |
| ② 제산제       | 속이 쓰리거나 신트림이 날 때 사용                                        |
| ③ 위산분비 억제제  | 위산분비가 상당히 많아서 속쓰림, 신트림이 심할 때 사용                            |
| ④ 소화효소제     | 과식, 질긴음식 과다섭취 후 복부불쾌감, 소화불량증에 사용                           |

### (2) 정신요법 소화기 환자 모두에게 적용되므로 알아둬야 함

- ① 철저한 검사를 시행해 의사가 진단에 대한 확신을 가진다.
- ② 환자에게 기능성 질환의 개념을 설명하여, 이는 악화되거나 합병증을 일으키지 않으며  
나을 수 있다는 확신을 준다. ★
- ③ 의사와 환자 간의 신뢰 관계를 확립한다.
- ④ 환자의 가정, 직업, 사회 등으로부터 오는 불안, 초조, 우울 등을 극복할 수 있게 심리  
요법을 실시한다.
- ⑤ 신경안정제를 사용한다.

### ☞ 가정의학과 우울증 환자 case

- 직업이 가정의학과 의사인 환자
- 코로나 때 코로나 약을 먹으며 무력감 설사 등의 증상이 생김.
- 나중에 공황장애까지 와서 그 약을 먹어도 우울감이 너무 심해짐. 그래서 부모님이 데리고 와서 2주  
정도 입원함.
- 양방의사면 자기가 알아서 처방을 잘 했겠는데, 이 사람은 우울감이 너무 심해 보여서 교수님께서서는  
환자의 두려움을 없애주는 것이 좋겠구나 생각함
- 이후 회진 시 내내 걱정마세요 나올거예요 라는 얘기를 많이 해줬더니 호전됨.
- 환자의 신뢰관계는 손을 잡고 이렇게 아니라 환자가 말하는 것에 대한 적극적 대답임.

### (3) 식이요법 슈퍼패스함

- ① 가능한 부드러운 음식을 사용하고 질기거나 거친 음식은 삼간다.
- ② 과식을 피하고 식사시간을 잘 지킨다.
- ③ 조미료, 기호품의 사용은 가능한 한 제한한다.
- ④ 식사시간을 길게 하고 음악을 듣거나 대화를 함으로써 유쾌하게 식사한다.
- ⑤ 이전에 먹고 좋지 않았던 음식은 삼간다.

## 하부 위장관 기능장애 과민성 장 증후군 (IBS)

### ☑ 진단의 필수요건

- 복통, 배변 습관의 변화 등이 특징적인 만성 기능성 장애
- 증상들의 기질적 원인을 배제할 수 있는 제한적 평가
- 증상이 일반적으로 10대 후반 ~ 20대 초반에 시작한다는 점
- 다양한 정도의 불안 또는 우울

⇒ 배변장애, 복통, 복부팽만감 등의 증상이 있으나 기질적인 병변이 없음이 확인된 예를 총망라한 임상 증후군으로 단일질환이 아님

### 1) 정의

⇒ 다음 증상 중 적어도 3개가 있어야 함 + 증상을 설명할 수 있는 기질적 질환 없어야 함

#### (1) 복통 아랫배가 사르르 아픔

- 배변 후 완화되거나 그 횟수/경도의 변화와 연관된 복통
- 하복부의 간헐적 경련성 복통 → 대변에 의해 소실됨
- 스트레스, 음식섭취 1-2시간 이후 악화됨
- 저녁에 발생하거나 환자의 수면을 방해하는 경우는 거의 없음 ★

#### (2) 鼓腸<sup>고장</sup> : 배에 가스가 차서 팽팽하며 갑갑한 것. 복부팽만 또는 창만

↳ 최근 인스턴트, 외식 문화로 환자 늘어남. 보통 노인, 소아에게 호발

#### (3) 방귀

#### (4) 장명: 배에서 우글우글하는 소리가 남

#### (5) 배변횟수와 변의 경도의 변화. 변비 혹은 설사가 번갈아 나는 것

- 횟수의 변화: 3회 이상/일, 3회 미만/주
- 형태의 변화: 덩어리지고 단단함 / 수양성
- 배변 시의 변화: 긴장, 절박감, 불완전한 배출, 팽만, 복부팽창, 점액배출
- 변비: 배변행위의 감소, 딱딱한 변, 소량의 변
- 설사: 무른 변, 잦은 배변행위, 절박감, 변실금

↳ 설사형이 환자의 80-90%

↳ 변비형은 건강기능식품(주로 차전자피) 등을 먹어서 해결하는 경우가 많으므로 병원의 내원이 적음

+ 다른 신체적 정신과적 기능성의 증상(우울, 불안 등)들을 호소하기도 함

### 📌 과민성 장 증후군 환자의 하루.. ^^

- 1) 아침에 배가 아파서 깬. 이후 화장실 다녀오면 복통 사라짐 - 아침에 화장실 가야하므로 일찍 일어나  
↳ 심지어 하루의 첫 대변 상태로 하루의 일진을 정하는 환자도 있음 ..
- 2) 언제 설사를 할지 모르는 불안감에 대중버스를 잘 이용하지 않음
- 3) 식전, 식후에 설사를 주로 하고 심하면 낮(오후)에 설사를 더 함

### 📌 자바로 입원한 과민성 장 증후군 환자 case

- 1) 교통사고로 입원한 여성 환자. 알고보니 우울증이 심하고 과민성 장 증후군이 있음
- 2) 본인은 과민성 장 증후군인 줄도 모르고 있었음
- 3) 애들 데리고 일박 이일 여행 한 번 다녀오는게 소원인데 이루지 못했음
- 4) 일년 정도 치료 후 호전되고 여행도 다녀옴. 20년간 과민성 장 증후군이었는데 몰랐다가 호전되니 세상이 달리 보이고 삶의 질이 개선됨

### 📌 장관 가스 과다 48세 남성 환자 case

- 1) 숨이 찬 것이 주소증인 환자
- 2) 부항하기 위해 옷을 올렸는데 뒤에서 봐도 가스가 매우 차서 불룩해진 거어 보임
- 3) 복진해보니 구미혈까지 가스가 치밀어 올라 심하며 X-ray 찍어보니 내부에 변도 많음
- 4) 첫날 사하제 썼더니 숨이 쉬어지고 배가 줄어서 왔음

### 2) 역학 넘어가심. 프린트 참고!

### 3) 원인

- ① 운동성의 이상
- ② 항진된 내장 통각수용: 환자에 따라 내장의 동통역치가 감소되어 있을 수도 있음  
- 절대적 장내 공기의 양은 정상과 같으나 복부팽창 호소
- ③ 정신 사회학적 이상: 환자의 절반 이상 우울, 불안, 신체화 장애 등의 기저질환 O
- ④ 유전적 체질: 자율신경의 과민성, 부모의 영향
- ⑤ 유소년 시의 위장질환: 가족의 과보호, 부적절한 식사, 배변습과, 신경증적 성격

### ✓ 증상을 유발하거나 악화시키는 인자

|    |                                              |
|----|----------------------------------------------|
| 식이 | 찬 음식, 뜨거운 음식, 섬유질 많은 음식, 주류, 불규칙한 식생활 및 배변활동 |
| 과로 | 정신/육체적 만성피로, 신체를 차게 하는 것, 상기도감염, 출산, 갱년기     |
| 기타 | 복부수술, 장염 후, 심리적 인자, 대인갈등, 가족문제, 실연, 우울증 등    |

✓ 증상을 지속 고정시키는 인자

|        |                                       |
|--------|---------------------------------------|
| 환자측 문제 | 성격변화, 신경증적 반응, 증상오해, 자기암시, 질병으로 얻는 이득 |
| 기타     | 자연조건반사 기전의 형성, 의사의 암시에 의한 치료상의 과오     |

#### 4) 임상소견

(1) 배변습관의 변화: 지속적 설사 / 심한변비 / 설사 변비가 번갈아 일어남 (가장흔함)

① 무통성 설사형

- 항상 묽은 변 but 통증 거의 X
- 흡수장애, 탈수, 체중 감소 등의 이차적 설사 합병증 없음
- 아침에 식사 전후에 3~4번 묽은 변을 보고 나면 하루종일 무사히 보냄
- 밤에 자다가 설사 때문에 깨어나는 경우는 매우 드물
- 항복성 성격, 자포자기형, 우울성, 죄책감, 슬퍼하기 쉬운 성격
- 장의 분절운동 감소되고 변의 진행이 빨라져 설사 발생

② 변비와 설사의 주기 반복형: 특별한 원인 없이 설사와 변비가 주기적으로 반복

③ 경련성 변비형 읽어보시면 되구요~ 하고 넘어감

- 변비가 심하면서 복통을 수반
- 배변 후 통증 소실 / 변횟수 증가되며 통증 발생 / 변 묶어지며 통증 시작
- 복부팽창됨 / 변 보고 나서도 충분히 본 것 같지 않음 / 점액변

#### (2) 복통

- 좌하복부 > 우하복부 > 우상복부 > 좌상복부
- 발생부위가 애매하여 변동이 많고 자주 이동되는 것이 특징 = 氣滯
  - ↳ 보통 기체의 원인은 스트레스, 간기울체형, 간기범위, 간비불화 多
  - ↳ 설사가 심하지 않으면 시호소간탕 등을 씀

① 비만곡부증후군

- 통증이 좌상복부에 국한되어 자주 나타나는 경우
- 연하된 공기가 트림에 의하여 밖으로 배출되지 않고 장내로 배출되어 광범위한 고창을 일으키거나 대장의 비굴곡부에 모여 이 부분이 확장되어 좌상복부의 팽만감 및 압박감을 느끼게 되고 좌흉부로 통증이 반사하는 증상

② 간만곡부증후군

- 통증이 우상복부에 국한되는 경우
- 양와위에서 환자의 늑골 아래 만져지는 간의 타음을 들었을 때, 둔탁음이 아닌 고타음이 난다.

#### (3) 복부 팽만감

- 鼓腸<sup>고장</sup>, 불쾌감, 방귀 등
- 하복부에 가스가 많이 찬다고 호소 + 방귀를 자주 땀, 가스가 배출되면 복통 ↓
- 실제로 가스의 양보다는 장벽의 수축으로 내압이 증가하는 경우가 더 많음  
↳ 젊은인은 평활근 수축 보통 괜찮음 but 노인들의 경우 계실의 원인이 되기도 함
- 관강내압이 높아지는 것은 장 크기 감소와 다발성 계실의 발생과 연관 O

#### (4) 전신증상 ★

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 자율신경계 증상 | 두통, 어지럼증, 월경불순, 배뇨장애, 심계항진, 도한<br>- 월경불순: 월경 전후에 증상 악화, 1/3 월경통 호소<br>- 배뇨장애: 빈뇨, 배뇨 시 통증 |
| 정신신경 증상  | 불안, 초조, 우울, 수면장애 (중간에 깨진 않음)                                                              |

#### (5) 기타 넘어가심

- 체중 / 오심구토 / 소화불량, 연하장애 / 맹장수술 경력 / 암공포증 / 합병증(계실)

#### 5) 진단법 넘어가심

대부분의 검사에서 정상 but 대장내압, 장근전도 검사에서 위대장반사의 항진 O

#### 6) 감별진단

협심증, 담도질환(담석증), 충수염, 계실염, 요로결석증, 자궁주위염, 소화성 궤양, 임파종, 대장암, 유당불내증

- ↳ 복강경 시술, 개복수술 등의 수술 여부를 만드시 문진 시 물어봐야 함
- ↳ 수술 이후의 유착이 피곤하고 과로하였을 때 통증이 생길 수 있기 때문



## 7) 치료법 쪽 한 번 읽어보라고 하시고 숙 넘어가심

- 제일 중요한 치료) 기능성 증상의 경과와 환자를 안심시키는 의사의 설명  
= 환자와의 치료적인 관계 정립하는 것 중요 + 기능성 장애임을 강조  
⇒ 의사와 환자 간의 신뢰 정립이 가장 중요!

### (1) 약물요법

- 보존적 요법에 잘 반응하지 않는 심한 증상을 가진 환자에게 필요 (보조적 방법)
- 항경련 약제 / 지사제 / 항변비제 / 항정신성 약물 / 기타(항불안제, 마취제)

### (2) 정신요법

### (3) 식이요법

- ① 식후 통증 유발 음식, 증상 악화 음식 피하기 + 골고루 잘 먹기
- ② 알콜, 담배 禁
- ③ 급성기에는 자극성, 섬유질 음식 피함
- ④ 유당, 과당, 솔비톨의 흡수장애 등

### (4) 생활지도

- ① 적당한 운동, 휴양, 수면, 놀이, 규칙적 식사, 배변습관 확립, 과음 X, 금연
- ② 과로, 폭음, 폭식, 몸 차게 하는 것 피하기

#### 📌 과민성 장 증후군의 운동 치료 - 교수님이 생각하는 근본치료

- 기능성 소화불량증보다 운동에 의해 크게 좌우되는 과민성 장 증후군
- 운동 시 인위적으로 장 운동이 이루어지고 혈액순환과 림프순환이 원활해져 장 내 독소제거가 잘 이루어짐
- 추천 운동) 승마 or 가볍게 뛰기

## 한의학적 고찰

이미 다 외웠던 거죠? 하면서 3분만에 넘어가셨습니다 .. !

교수님이 언급하셨던 간기울결, 기혈량허, 비위량허 등 정도만 기재해놓겠습니다. 나머지는 유인물 참고!

### 변증시치

#### ✓ 간기울결 (제일 多)

- 증상: 완협창통 / 통무정처 / 완민애기 / 복창납매 / 흑건구토 / 반정신억울 / 정서불녕 / 선태식 / 설태박니 / 맥현
- 치법: 소간이기해울
- 처방: 시호소간산

#### ✓ 기혈량허

- 증상: 신피권태 / 기단라언 / 면색무화 / 구순색담 / 심계두훈 / 납소 / 식후난소 / 우유복통 / 향문하추 / 설담반변유치훈 / 태박백 / 맥세약
- 치법: 쌍보기혈
- 처방: 팔진탕

#### ✓ 비위허

- 증상: 완복외한희온 / 득열음즉서 / 지냉변당 / 심흑활탈불금 / 완곡불화 / 납소신평 / 설담 / 태활 / 맥침세
- 치법: 온비완위 , 산한통양
- 처방: 부자이중탕

## 소화불량 교과서 정리 p. 264

교수님 曰: 책 샀으니 한 번 봐야겠조?

하면서 스펙 읽으시고 넘어가셨습니다. 언급하신 부분만 정리하겠습니다! 나머지는 교과서 참고.

### (1) 개요

- 소화불량은 1차 진료기관에서 많이 접하게 되는 가장 흔한 증상 중 하나
- 대부분 환자에서는 기질적 질환을 발견할 수 없음
- 환자의 호소 증상: 상복부의 지속적/재발성 동통이나 불편감 등
- 대표적 증상: 식후 포만감, 식후 불쾌감, 상복부 이물감, 상복부 중괴감 ... 등 ..

### (2) 원인

- 기질적 질환에 대한 특징을 모두 문진하여 감별진단을 해야하므로 알고 있어야 함

### (3) 소화불량증으로 흔히 기술되는 증후군들

#### ① 통증

- 동통의 양상 및 동통장기와 동통부위의 관계 **홍골하** 통증은 심장질환티 통증과 감별해야 함
- 소화불량증의 통증의 시간적 관계
- 통증과 식사와의 관계

#### ② 비궤양성 소화불량증 넘어가심

#### ③ 가슴쓰림: 일반적으로 식도의 이상을 나타냄 (심장질환에서도 발생 가능)

#### ④ 음식불내증: 특정 음식물이 소화불량과 연관됨 ex) 우유, 계, 갑각류 등

#### ⑤ 공기연하증

#### ⑥ 가스팽만

#### ⑦ 장외질환에 의한 소화불량

#### ☞ 담석증 할아버지 case - 알고보니 교수님의 아버지

- 소화가 안되고 복통 증상 생김 → 교수님이 약 처방해주시고 2주 뒤 또 소화 안된다고 하심  
→ 침치료 후 또 약 처방 → but 완전히 낫지 않고 2~3주동안 증상의 악화, 호전 반복됨
- 이후 양약도 처방받음 → 교수님이 전화해서 괜찮냐고 물어봤는데 약 먹을 때만 증상이 호전된다고 함  
(알고보니 교수님이 품쳐놓은 양귀비 끊어드셔서 그 때만 괜찮아진 것 .. )
- 교수님이 좀 뒤에 직접 집에 가서 아버지 보니 안색이 안 좋아서 내과병원 데리고 가서 초음파 함
- 초음파 프로브 대자마자 미친개처럼 담낭 발견 - 거의 폐혈증 직전 → 결국 응급수술함  
⇒ 가능성 있는 원인들을 모두 확인하고 배제할 필요가 있음

## 기능성 소화 불량 교과서 정리 p. 345

### (1) 개요

- 식사여부와 관계없이 주로 상복부 중앙에 복통이나 불편감이 있는 경우
- 기질적 원인이 밝혀진 경우 / 병태생리학적, 미생물학적 이상 소견의 임상적 의미가 아직 확실하지 않은 경우 / 이상 소견이 관찰되지 않은 경우

### (2) 원인

- ① 위산
- ② 소화관 운동: 위, 십이지장 운동 / 십이지장위 역류 / 소화관 호르몬
- ③ 내장감각역치
- ④ 만성 위염과 H.pylori
- ⑤ 정신사회적 요인
- ⑥ 환경적 및 유전적 요인

### (3) 진단

- ① 기능성 소화불량증의 진단 기준
- ② 소화불량증 환자에서 감별진단을 위한 임상적 평가

### (4) 치료

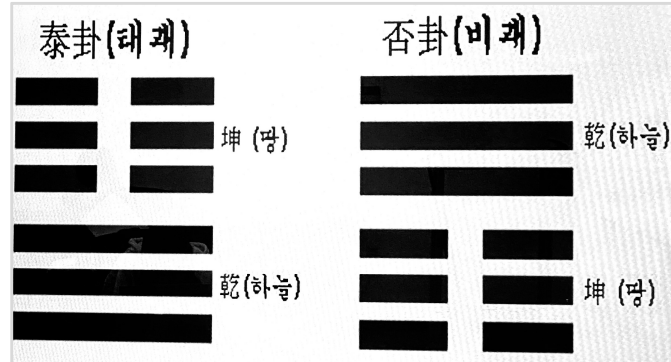
- ① 한의사와 환자의 관계
- ② 생활습관 및 식이조절
- ③ 약물치료
- ④ 정신과적 치료

### (5) 한방치료

- 비위허약 / 간위불화 / 위음부족 / 위장정음 / 어혈정체

# 비만증 痞滿

## ✓ 꽤로 보는 비만증 (ppt)



- 태괘: 상하가 소통이 잘 되는 상태. 곤(陽)상 / 건(陰)하
- 비괘: 상하가 소통이 잘 안되는 상태. 건(陽)상 / 곤(陰)하  
↳ 비주승 위주강이 잘 되어야 하는데 상하가 반대로 된 상태  
= “ 痞滿 ”

아래에서부터는 교과서 내용! (꼭 읽으시며 수업하심)

## 1) 개요

- 痞滿: 상복부<sup>心下</sup>가 막혀서 답답하고 痞塞 가슴이 가득차서 답답하며 滿悶 만져도 형체와 통증이 없는 증상
- 기질적, 기능성 병변을 모두 포함하며 만성위염, 기능적 소화불량, 역류성 식도질환, 식도협착 등의 질환이 포함됨
- 대부분 기거실조, 음식불화, 기울담응으로 인하여 비의 운화와 승강실조로 발병함
- 예후: 비교적 양호, 환자의 정신을 유쾌하게 하고 음식조절과 운동을 통한 체력단련을 하면 회복이 빠름

## 2) 병인병기

|                        |                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 誤下傷中 <sup>오하상중</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 상한사기가 肌表에 있는데 반대로 裏를 공격하여 잘못 사하시켜 사기가 허한 곳을 틈타 心下에 맏혀 비만을 이룸</li> <li>• 상한의 사기가 표에서 리로 미쳐 胸과 胃口로 들어가면 비만이 발생</li> </ul>                                |
| ② 飲食阻滯 <sup>음식조체</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과음이나 포식 혹은 恣食生冷<sup>자식생랭</sup> 하여 中陽이 손상되면 비위의 納·化·升·降 기능에 영향을 미쳐 심하비만不舒, 飲食不振<sup>음식부진</sup> 등이 발생한다.</li> </ul>                                      |
| ③ 痰氣壅塞 <sup>담기옹색</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비위가 수습운화를 하지 못해 담탁이 생기면 담기가 중초를 옹색하여 清陽이 상승하고 탁음이 不降하므로 비만이 발생함</li> <li>• 담기가 흉중의 淸曠之地<sup>청광지지</sup>로 상역하면 흉만이 발생함</li> </ul>                        |
| ④ 七情失和 <sup>칠정실화</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 多思則氣結<sup>다사즉기결</sup>, 暴怒則上氣<sup>폭노즉상기</sup>, 悲憂則氣鬱<sup>비우즉기울</sup>, 驚恐則氣亂<sup>경공즉기란</sup> 등으로 인하여 기기가 역란하면 승강이 불리하여 비만이 발생함</li> </ul>                |
| ⑤ 脾胃虛弱 <sup>비위허약</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 평소 비위가 튼튼하지 않고 중기가 久虛하거나 飢飽不常<sup>기포부상</sup>하거나 혹은 生冷硬物을 과식하거나 혹은 비감후미를 절제하지 못하거나 혹은 병중에 한랭극대지제(찬약)을 과용하여 비위의 기를 손상시키거나 병후에 위기가 회복되지 않아 발생함</li> </ul> |

## 3) 진단 및 감별진단

### (1) 진단

- 자각적으로 심하가 폐색불통하고 흉격이 滿悶不舒하며 겉으로는 심하나 흉격에 脹急한 형태가 없어 단지 滿而不痛<sup>만이불통</sup> 한 증 = 본인은 느끼지만 외부로 보이기엔 창만하지 않음!

✓ 비에 있으면 기본적으로 지양혈을 압통해봄. 보통 손도 못 대게 할 정도로 아픔을 느낌  
이 부위에 건부항, 사혈 등을 하면 트림하며 통증이 완화되기도 함

### (2) 감별진단

|                  |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 脹滿 <sup>창만</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 뱃속이 창급하고 겉으로도 복부창대한 형태가 나타남</li> <li>• 심하 혹은 흉완이 자각적으로 滿悶不舒하며 외부로는 창급한 형태 X</li> <li>• 비만은 주로 흉격, 심하, 위완 등에 나타남</li> <li>• 창만은 주로 복부에 나타남</li> </ul> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胸痺 <sup>흉비</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>주증으로 하는 3대 증상: 흉민 / 흉통 / 短氣</li> <li>흉증이 비색불통하여 胸膈部<sup>흉읍부</sup> 내외에 동통이 발생하는 병증<br/>↳ 소화기 질환보다는 심장병을 표현한 것 같음</li> </ul> |
| 結胸 <sup>결흉</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>심하에서 소복까지 단단하고 답답하며 아파서 손을 댈 수 없음</li> <li>반대로 비만은 답답하기만 하고 아프지 않으며 손을 댈 수 있음</li> </ul>                                   |

#### 4) 변증 요점 대충 읽고 넘어감

- ① 有邪, 無邪의 변별
- ② 허실한열의 변별
  - 허: 비만하며 음식을 먹을 수 없고 혹은 소화시킬 수 없음 + 설사 + 희안
  - 실: 음식을 잘 먹지만 대변이 잘 안 나옴 + 비만 감소하지 않고 거안함

#### 5) 치료원칙 읽어보라고 하시고 넘어감

(1) 비만 치료에는 **허실 구별**이 먼저

- 그러나 보통 허실착잡(허+실 같이 있는 경우)이 많으므로 消補兼施法<sup>소보겸시법</sup> 사용

(2) 주요 증상은 “**심하비만불서**” 이므로 일반적으로 理氣通導法<sup>이기통도법</sup> 상용  
but 장기간 or 다량 쓰면 안되므로 장기간 복용하면 안됨

(3) 비증의 일반적인 치료방법 by 동의보감 - 언급한 것만 정리함

- ① 비만증의 주약: **지실, 황련** (를 가미해서 씀)  
ex) 간기울체 환자: 소달건비탕에 가미 / 오래된 허증 환자: 보중익기탕, 황련백출탕에 가미
- ② 살찐 사람의 비증(담탁 때문): **창출, 반하, 복령, 사인, 활석**
- ③ 마른 사람의 비증(울열 때문): **지실, 황련, 갈근, 승마**
- ④ 비만증의 왕도는 “**消導**”

## 6) 변증시치

### (1) 胃脘食滯 위완식체 ★

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| ① 증상 | 홍완비만, 비색불서, 애부탄산, 오심구토, 흑능식이대변불통, 복만거안, 설태담탁, 맥현활 |
| ② 치법 | 소도화위                                              |
| ③ 치방 | 보화환, 평위산, 지출환                                     |

### (2) 痰濕內阻 담습내조

|      |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 완복비만, 만민불서, 두목현훈, 흉민불기, 오심욕토, 신중권태, 홍해담불상, 소변황삽, 설태탁니, 맥활<br>✓ 흉민불기: 그득하니 차 있는 느낌 때문에 배고픈 것을 모름 |
| ② 치법 | 거습화담, 순기관증                                                                                      |
| ③ 치방 | 평진탕, 선복화대자석탕<br>✓ 선복화: 담탁내조의 첫 번째로 쓰는 약                                                         |

### (3) 肝氣鬱結 간기울결

|      |                                                                      |
|------|----------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 흉민불서, 비색만민, 심번이노, 양협작창, 흑시작탄식, 설태박백, 맥현<br>✓ 시작탄식: 나도 모르게 아무 때나 한숨 씀 |
| ② 치법 | 소간해울, 이기소체                                                           |
| ③ 치방 | 월국환, 사마음                                                             |

### (4) 脾胃虛弱 비위허약

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 홍완불서, 비색창만, 시관시급, 부지기, 불욕식, 희열희안, 득온즉서, 사지불난, 기단핍력, 체권나연, 대변희당, 설담태백, 맥침현, 흑허대무력 |
| ② 치법 | 보기건비, 승청강탁                                                                       |
| ③ 치방 | 보중익기탕, 이중탕, 반하사심탕, 감초사심탕, 생강사심탕                                                  |

## 7) 비증의 분류

언급하신 것만 정리함 - 읽어보시고~ 넘어가버림

- 동의보감 기준의 분류: 한비, 열비, 실비, 허비 등으로 분류
- |                                     |
|-------------------------------------|
| ① 雜病之痞                              |
| - 久痞滿: 황련소비환 → 스트레스로 인한 소화불량증에 잘 들음 |
| ② 傷寒之痞: 반하사심탕, 황련사심탕, 부자사심탕 ... 등   |

## 8) 경과와 예후

## 9) 예방과 조리

8), 9) 모두 그냥 넘어감!

# 애기<sup>噯氣</sup>

여기도 교과서 내용! 언급하신 것 위주로 정리함

## 1) 개요

- 위중의 탁기가 상역하여 식도를 경유하여 입으로 배출되는 병증
- 원인) 感受외사, 음식부절, 담화내오, 칠정내상 등으로 비위불화, 청탁승강실상을 일으켜 위로 기억하게 됨으로 발병함
- 대개 병후나 노인으로 비위가 허약한 사람에게 多 + 간기횡역의 경우도 있음
- 서양의학적: 위무력증, 만성위염, 위산부족증, 만성장염, 신경성 소화불량이 애기의 범주

## 2) 병인병기

|        |                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 식적내정 | 생냉/魚腥이나 粘滑하여 소화가 어려운 음식을 과식하여 비위를 손상하면 수납과 운화 기능이 상실되고 속식이 중초에 체류하여 음식이 소화되지 않아 창만/기역함 |
| ② 감수외사 | 기후의 이상으로 풍한이 침습하여 한기가 위부로 침입하면 중초의 기가 滯而不行하여 상역하므로 애기가 발생함                             |
| ③ 정서불화 | 憂思惱恐으로 인하여 칠정이 손상되면 肝失調達하고 간기가 횡역범위하여 위기가 순강하지 못하여 애기가 발생함                             |
| ④ 비위허약 | 병후에 사기留連하고 위기가 허약하여 화평하지 않거나 본래 몸이 허약하여 비위가 虧虛하고 운화기능이 무력하면 기체중초하여 허기가 상역하므로 애기가 발생함   |

### 3) 변증시치

#### 【 실증 】 식체불화 위중담화 간위불화

##### (1) 食滯不化 식체불화

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 식후애기빈작, 기미산부이취, 복중포창, 흥완비민, 흑오심구토, 흑복통<br>대변취예당설, 흑변비불통, 설태후탁, 맥활 |
| ② 치법 | 건비화위, 소식도체                                                        |
| ③ 처방 | 보화환                                                               |

##### (2) 胃中痰火 위중담화

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| ① 증상 | 애기흥민, 구갈순건, 흑구토담연, 흑검해수담질점조, 설질홍, 태황니, 맥활<br>삭 |
| ② 치법 | 청열화담, 화위강역                                     |
| ③ 처방 | 온담탕 가 황련, 금은화                                  |

##### (3) 肝胃不和 간위불화

|      |                                                    |
|------|----------------------------------------------------|
| ① 증상 | 애기작시, 흑검복창불상음식, 흑검정신억울이창, 상인정신격유발흑가중, 활<br>태박니, 맥현 |
| ② 치법 | 소간이기, 강역화위                                         |
| ③ 처방 | 사역산 (+소달건비탕 등)                                     |

#### 【 허증 】 간위허한

##### (1) 肝胃虛寒 간위허한

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 애기시작시지, 애성저약, 식욕불창, 신피핍력, 사지불온, 면색소화, 흑범토<br>청수, 설질담, 태백운, 맥지완 |
| ② 치법 | 온중거한, 보익비위                                                     |
| ③ 처방 | 이중환, 육군자탕                                                      |



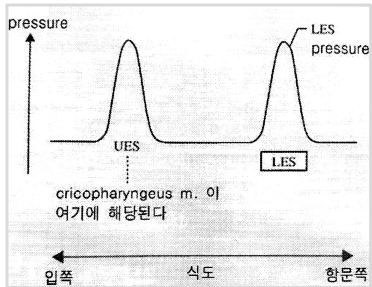
## 식도질환

★ 식도염 역류성 식도염 하부식도 괄약근 이완불능증 식도암 ★

### ✓ 식도

- 중층 편평상피로 피복된 근육성 관통기관
- 길이: 25~35cm
- 생리적 기능에 따른 분류
  - └ 상부식도 괄약근: 인두와 식도를 나누고 흡기 시 식도로 공기가 들어가는 것 방지
  - └ 식도체부
  - └ **하부식도 괄약근**: 위액이 식도로 역류하는 것 방지

### ✓ LES pressure



- LES가 압력을 가함으로써 위에서 식도로 음식물이 역류하는 것을 막는다.
- 증가: 식도의 협착과 연하곤란
- 감소: Hiatal hernia, 역류성 식도염

## 식도염

### 1) 식도염의 분류

- └ 급성 식도염: 기계적, 화학적 자극에 의해 갑자기 발생
- └ 만성 식도염: 폭음가, 애연가에게 多
- └ 기타: 역류성 식도염, plummer 빈혈 증후군, 식도매독, 결핵 및 부식성 식도염 등
- + ) 원인에 따라 세균성 인자, 화학적 인자, 물리적 인자, 외상에 의한 식도염 등

### 2) 병인

|                |                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 세균성 인자       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 타장기, 기관으로부터 파급되는 것</li> <li>• 인두염, 후두염, 구내염, 편도선염, 성홍열, 폐렴, 마진, 두창, 매독 등의 염증으로부터 옮겨지는 경우가 대부분</li> </ul> |
| ② 화학적 인자       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 강산, 강알칼리, 승홍(HgCl<sub>2</sub>) 등의 음용, 위약의 식도역류 등</li> </ul>                                              |
| ③ 물리적 인자 or 외상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 과냉물, 과열물을 오음했을 때 (개뜨거운 만두), 이물에 의한 손상 (생선뼈), 내시경에 의한 상처 등</li> </ul>                                     |

⇒ 식도는 외부물질이 가장 먼저 닿는 곳으로 음식섭취에 직접적인 영향을 받음

#### ✏ 애 키울 때 조심

- 옆과 과장님 아기가 배 아프대서 엑스레이 찍었는데 건전이 있어서 초음파 수술함
- 레고 등 아이가 눈 깜짝할 사이에 삼킬 수 있으므로 유의해보자

- 기타 중추신경계 질환이 있을 때, 광범위한 화상 또는 외상 후, 수술 후 특히 구토가 심하거나 또는 위관을 장기간 유치하였을 경우, 식도까지 확대된 herpes성 구강질환 이 있을 경우, 또한 만성질환으로 쇠약해진 환자에게 항생물질 또는 부신피질호르몬을 사용하였을 때 잘 발생한다.
- 50대 이후 환자들의 경우 예전의 개복수술 기왕력을 물어보아야 함. 개복수술 등의 기왕력이 있는 환자의 경우 컨디션이 떨어지면 수술 부위의 유착으로 인한 통증이 발생할 수도 있음

### 3) 증상

- ① 음식을 삼킬 때 악화되는 흉골하통증, 식도이물감, 식도작열감, 가슴이 따갑고 쓰림
- ② 식도점막 과사, 점막의 발적/종통/출혈
- ③ 부식성 화학물질에 의한 식도염: 치명적일 수 있으며 광범위한 식도협착
- ④ 2차적 질환으로 발생한 식도염 환자는 쇠약과 빈혈, 구토에 의한 식도의 외상에 의한 증상들이 나타난다

### 4) 합병증

- 상기도 감염증, 식도협착 등이 있으며 특히 酸分泌物이 염증을 일으켜 식도점막의 표층성 궤양을 일으키며 계속되는 잦은 출혈로 인한 빈혈과 치유된 후에도 재발이 반복됨에 따른 섬유성 협착이 나타남

### 5) 감별증상

- 자율신경실조증
- 암공포증 환자: 임상검사에서 병적 소견이 나타나지 않으나 연하장애, 흉골배부의 위화감 등의 증상을 호소함.

#### ☞ 감별진단 해야 할 것

- 인후 이물감, 가래, 기침, 목이 간질간질할 때 감별진단이 필요함
- 매핵기, 만성 후두염, 축농증, 후비루 또한 증상이 유사하므로 감별진단 필요함

### 5) 치료

- ① 식도의 안정을 보전함이 원칙
- ② 경증: 유동식 섭취 / 중증: 수일간 절식 + 식도 확보 위해 위관을 사용
- ③ 부식성 화학물질을 마셨을 때: 구토 내지는 설사 유도하든지 흡착시킴
- ④ 2차 질환으로 유발된 식도염: 원발성 질환을 치료
- ⑤ 처방: 반하후박탕, 화중길경탕, 치자시탕, 소함홍탕, 개기소담탕

## ★ 역류성 식도염 ★

### ✓ 역류성 식도염

- 산성인 위액이나 알칼리성인 장액의 역류에 의해 초래되는 식도 점막의 염증.
- 역류성 식도질환으로 인해 식도의 점막에 염증 등과 같은 기질적 변화가 생긴 것
  - └ 역류성 식도질환: 질환이 되는 원인을 제거하는 데에 중점을 뒀야 함
  - └ 역류성 식도염: 식도 점막의 재생에 중점을 뒀야 함

### 1) 원인 — LES의 기능 저하

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ① LES pressure 저하 | 흡연, nitrates, 칼슘채널차단제 사용                                              |
| ② 식도의 연동저하        | 식도 내에 산성 물질이 정체되어 식도 점막에 장애<br>⇒ 물을 수시로 먹어 위산이 올려준 것을 내려주게 해야 함       |
| ③ 위산분비 항진         | 역류하는 위 내용물이 식도를 손상<br>⇒ 산사, 신곡, 맥아로 위위 내용물 내려줌                        |
| ④ 위의 운동연동 저하      | 위 내용물이 원활하게 소장으로 보내지면 역류가 줄어들                                         |
| ⑤ 중력              | 취침 시 몸을 옆으로 누이면 역류가 더 잘 일어나게 됨<br>⇒ 상체 20도 정도 높게 해서 자거나 역류성 식도염 베개 이용 |

### 2) 증상

- ① 속쓰림: 흉골 밑이 “타는 것 같고 쓰림” → 누워있거나 구부렸을 때 더 심함
- ② 역류: 야간 취침 시 위 내용물이 입으로 역류 + 기침, 질식을 일으키기도 함  
특히 와상환자 or 노인분들에게 多
- ③ 연하 시 흉통: 음식물의 연하 시 통증을 느낌 (거의 대부분 환자에게 있음)
- ④ 연하곤란: 음식물의 연하 시 통증을 느낌
- ⑤ 출혈
- ⑥ 폐증상: 기관지염, 기관지 천식을 일으키기도 함
  - └, 최근 역류성 식도염에 의한 만성 기침이 늘어나는 추세
  - └, 코로나후유증기침: 기관지모세섬모들 예민해짐 (폐음허,폐신음허 - 맥문동탕가미, 청상보화탕)

### 3) 병발증

|         |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| ① 식도협착  | 역류에 의한 염증이 점막하층으로 파급되어 섬유조직 형성                       |
| ② 식도궤양  | 지속성 통증을 유발 / 출혈 가능                                   |
| ③ 바레씨상피 | 정상적 식도의 편평상피가 원주상피로 대체 (악성 잠재성 O)<br>⇒ 10%에서 선암이 병발함 |
| ④ 폐질환   | 위내용물이 역류로 인해 폐로 흡입돼 반복적 폐렴, 천식을 일으킴                  |

### 4) 치료

#### ① 생활습관의 개선

- 물리적 요법: 취침 시 머리를 15-20cm 높게 해 역류 방지
- 식사: 적은 식사량, 취침 전 2-3Hr 이내에는 먹지 않음
- 술, 고지방식, 초콜렛, 담배 등 LES 압력 낮추는 것 피함

#### ② 약물요법

- └ H2 blocker
- └ proton-pump inhibitor
- └ 항콜린제: 위산분비 억제 O but LES pressure를 저하시키므로 사용 X

#### ③ 외과적 요법: 하부괄약근이 너무 이완되었을 때 Nissen fundoplication

## 역류성 식도질환 교과서 정리 p. 314

### ✓ 역류성 식도질환

- 식도 내로 위산이 역류해서 임상증상을 나타내거나 식도에 형태조직학적 변화를 초래하는 경우
- 역류성 식도염 = 역류에 의하여 식도에 형태학적 병변이 일어난 상태

#### 1) 위식도 역류의 기전

: 위장 내용물이 역류되고 식도 하부의 역류 방지 기전이 깨져 발생함

#### ① 일시적 하부식도괄약근의 이완현상

- 복부 압력 증가, 위배출의 지연 및 위 팽창에 의해 위내 압력이 증가하면 미주신경 반사에 의해 하부식도 괄약근이 부적절하게 이완될 수 있음

#### ② 식도열공 헤르니아

- 하부식도괄약근을 둘러싸고 있는 횡격막이 수축하여 흡기에는 하부식도괄약근의 압력이 상승함
- 심한 역류성 식도질환 환자는 대부분 열공 헤르니아를 가지고 있음

#### ③ 낮은 압력의 하부식도괄약근

- 원발성 혹은 속발성 근력약화와 임신, 흡연, 약물, 수술, 식도염으로 인해 하부식도괄약근의 압력이 떨어지면 스트레스 역류와 자유 역류에 의해 위식도 역류가 일어남

#### 2) 식도 내로 역류된 위산의 청소

##### ① 거의 대부분 식도의 연동운동에 의해 제거됨

⇒ 연동운동이 잘 안되어 역류하는 경우에는 수시로 물을 먹게 해야 함

##### ② 그 후에도 남아있는 소량의 위산은 타액 속의 중탄산에 의하여 중화됨으로써 역류된 위산에 의하여 식도 점막이 손상되는 것을 방지해줌

### 3) 증상

#### ① 가슴쓰림

- 위산의 역류와 가슴쓰림은 역류성 식도질환의 전형적인 증상임
- 산이 식도 상피층의 깊은 곳에 위치하는 신경을 자극하기 때문에 발생

#### ② 흉통 ★

- 역류성 식도질환에 의한 흉통과 관상동맥 질환에 의한 심장성 흉통을 구분하기 어려움

#### ③ 이비인후과적 증상: 후두염, 후두협착, 성대결절 등 만성 후두질환의 원인

#### ④ 호흡기 증상: 만성적 기침과 천식이 임상적으로 나타날 수 있음

### 4) 합병증

- ① 역류성 식도염: 위나 장의 내용물이 식도내로 역류하여 식도점막에 손상을 줌
- ② 식도협착: 식도협착으로 인해 연하곤란이 일어나 협착부위가 위산이 식도 내로 역류되는 것을 막아 가슴쓰림과 같은 역류성 식도질환의 증상이 오히려 줄게 됨
- ③ 바렛식도: 지속적인 산역류로 인해 미란성 식도염이 낫는 과정에서 편평상피가 있어야 할 식도하부에 원주상피가 존재하는 상태

### 5) 치료

- 위식도 역류를 감소시키고, 역류물을 중화시키면서, 식도 청소율을 향상시킴으로써 식도 점막을 보호하는 것
- 일상 생활의 조절과 약물 요법 및 경우에 따라 외과적 수술요법으로 이루어질 수 있음
- 생활습관을 변화시키는 것이 치료의 기본

### 6) 한방치법

|      |    |                                                                        |
|------|----|------------------------------------------------------------------------|
| 간위불화 | 증상 | 흉완, 흉격에 작열감이 있거나 혹 작통하고 신물이 넘어옴. 음식이 막혀 안 내려감. 배가 답답하고 쓰림. 설태박니흑황체. 맥현 |
|      | 치법 | 서간화위강역                                                                 |
|      | 치방 | 사역산 합 소반하탕가미                                                           |

|      |    |                                                                                         |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 답습율조 | 증상 | 흉완/흉격의 작열감, 작통감 / 신물이 넘어옴 / 음식이 막혀 안 내려감 / 배답답 / 미식 / 마음불안 / 가슴벌렁벌렁 / 머리어지러움 / 설태니 / 맥활 |
|      | 치법 | 청화습담, 화위강역                                                                              |
|      | 치방 | 온담탕가미 (열 X: 계지 백출 / 담열 O: 황련 연교 가함)                                                     |

|      |    |                                                                                                     |
|------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 위기허역 | 증상 | 흉완/흉격의 작열감과 작통 / 신물 넘어옴 / 음식 막혀 안 내려감 / 배가 막힌 것 같음 / 신물 토함 / 음식 잘 못먹고 적게 먹음 / 면색백 / 힘없음 / 설질담 / 맥유약 |
|      | 치법 | 건비위, 강역기                                                                                            |
|      | 치방 | 향사육군자탕 합 선복대자탕가감                                                                                    |

# 탄산<sup>呑酸</sup>

역류성 식도염 = 한방에서의 탄산

<교과서 내용 정리 p.95>

## 1) 개요

- **呑酸** = 신물(酸水)이 위중으로부터 위로 올라오는 증상
  - ┌ **呑酸**: 咽下에서 발생된 것
  - └ **吐酸**: 酸水를 토출하는 것
  - └ **泛酸**: 가벼운 것 (시큼한 냄새가 올라옴)
  - ⇒ 모두 위통을 겸하는 경우가 많으나 단독으로 출현하기도 하며 치법은 모두 같음
- 대부분 간화내울, 위기불화로 발생하며 비위허한으로 운화가 안되어 발생되기도 함
  - ┌ 공격인자: 매운 음식, 자극적 음식, 위산분비과다 등의 인자가 공격함
  - └ 방어인자: 프로스타글란딘, 위점막 재생 속도 느림 등의 방어 인자가 약화됨

## 2) 병인병기

|                            |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① <b>음식실조</b><br>자극적, 단짠음식 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 음식부절 / 肥甘厚味 / 醇酒煎炸 등의 과식으로 비위가 손상되어 습열내생함</li> <li>• 부패, 변질된 음식을 먹고 소화시키지 못해 흉격이 鬱塞<sup>울색</sup>하면 위 기불화하여 탄산, 애기 발생</li> </ul> |
| ② <b>한사범위</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 갑자기 풍한을 감수하여 한사가 위로 침범하면 위양이 막혀서 습탁이 내정하고 울결하여 생김</li> <li>• 생냉물을 과식하여 중양이 손상되면 비위에 한사가 울체하여 생김</li> </ul>                      |
| ③ <b>칠정내상</b><br>by stress | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 鬱怒傷肝으로 간목의 소설기능이 막히고 기기가 阻滯되면 비위로 역승하므로 양옆구리가 창통하고 애기, 탄산이 생김</li> <li>• 思慮傷脾로 비위가 손상되어 중양이 부족하면 담탁이 안에 모여 탄산 발생</li> </ul>     |
| ④ <b>비위허약</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 품부부족, 노권내상으로 비위가 손상되어 음식량이 줄고 운화기능이 더더지며 애기, 탄산이 생기고 혹은 清涎이나 酸水를 토함</li> </ul>                                                  |

- ⇒ 대부분 간기울결 / 위기불화로 인해 발병함  
⇒ 그 중 한/열로 구분 가능!

## 3) 감별진단

### ✓ 탄산 呑酸 vs 조잡 嘈雜

- ┌ **탄산**: 胃中不適<sup>위중불적</sup> / 구토산수
- └ **조잡**: 위중공허 / 배고픈 것 같으나 배가 고프지 않음 / 매운 것 같으나 맵지 않음 / 아픈 것 같으나 안 아픈 것 같음 / 흥중오뇌 / 莫可名狀<sup>막가명상</sup> ...

⇒ 탄산은 위산과다 / 조잡은 위산부족 시 나타나는 증상들

## 4) 변증요점 한열을 분명히 가려야 함

- ┌ **한증**의 토산: 설질담, 태박백, 맥침지
- └ **열증**의 토산: 설질홍, 태황후, 맥현삭

## 5) 치료원칙

|                                                            |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>泄肝和胃</b> <sup>설간화위</sup><br><b>苦辛通降</b> <sup>고신통강</sup> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 간을 다스리면 위를 편안하게 할 수 있음</li> <li>• 열증의 토산에 적용</li> </ul> |
| <b>온중산한 화위제산</b>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 비위의 허한이나 중초의 한체로 발생한 토산에 적용</li> </ul>                  |

+ ) 식체(소도화위 병행) / 담탁유체(제담화습 병행)

## 6) 변증시치

### 1) 열증

|             |                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ① <b>증상</b> | 토산시작 / 애취부기 / 위완포민 / 대변취예 / 구건구갈 / 흑심번이노 / 량협창통 / 설질홍 / 태황후 / 맥현활 |
| ② <b>치법</b> | 설간화위, 고신통강                                                        |
| ③ <b>치방</b> | 좌금환                                                               |

### (2) 한증

|             |                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ① <b>증상</b> | 토산시작시지 / 흥완창민 / 애기취부 / 희타연말 / 음식희열 / 사지불온 / 피권핍력 / 대변변당 / 설담홍 / 태박백 / 맥침지 |
| ② <b>치법</b> | 온중산한, 화위제산                                                                |
| ③ <b>치방</b> | 향사육군자탕 가 오수유                                                              |

- 황기, 사삼, 작약: 위 점막 재생에 도움이 됨 (+ 옥죽 등)
- 유근백피: 위 점막 재생에 도움이 많이 되므로 위점막 재생이 늦어질 때(허증) 가미해줌

## 7) 탄산과 토산의 분류 제목만 알아두라고 하시고 넘어가심

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| ① 宿食留飲呑酸 숙식유음탄산 | ④ 胃冷呑酸 위랭탄산     |
| ② 痰火停食呑酸 담화정식탄산 | ⑤ 下焦虛冷呑酸 하초허냉탄산 |
| ③ 血虛火盛呑酸 혈허화성탄산 |                 |

|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 통용방 | 수련환 창련환 창련탕 증미이진탕 평간순기화중환 국출환 출령탕 투격탕<br>삼유환 사미수련환 구미수련환 황련청화환 청담환 |
|-----|--------------------------------------------------------------------|

### ✓ 증미이진탕 增味二陳湯

- 治呑酸: 간울기체 역류성 식도염 환자, 위산과다, 위궤양, 위장염
- 반하 진피 적복령 치자 황련 향부자 지실 천국 창출 백작약 신곡 감초

### ✓ 정전가미이진탕

- 治식적담, 導痰補脾, 소식행기
- 산사육 향부자 반하 천궁 백출 창출 백복령 굴홍 신곡 맥아 감초

## 8) 경과와 예후 pass

## 9) 예방과 조리

### (1) 예방

- 먼저 飲食有節해야 함
- 한량생냉한 것 + 酸, 辣, 煎, 炸을 과식하지 않아야 함
- 칠정의 조달에 주의하여 칠정의 요인 제거해야 함

### (2) 조리

- 적당한 휴식, 청담한 음식 섭취
- 거칠고 단단하거나 粘膩한 음식, 시고 매운 음식, 醇酒 X
- 자주 신물을 토하고 음식량 줄어든 경우엔 쌀죽 조금씩 자주 먹어 위기 기름

# 조잡<sup>嘈雜</sup>

〈교과서 내용 정리 p.95〉

## 1) 개요

“ 지랄같다 = 적절한 표현 ”

- 증상을 뭐라고 설명할 수 없는 병증 / 보통 애기, 탄산, 오심, 건구, 심하비, 위완통과 동시에 나타나며, 위열/위허/간울/혈허 등으로 발병
- 서양의학: 담즙 역류성 위염, 식도염, 위산과다증 등

## 2) 병인병기

- ① 음식부절: 소화하기 어려운 음식 과식하여 중초에 적체하고 담습이 안에 모여 울체하여 열을 화생하고 담열이 안에서 요란하여 발생
- ② 정서불화: 憂鬱惱怒<sup>우울뇌노</sup>하여 간의 조달기능이 실조하고 횡역하여 위를 침범하면 간 위불화되어 기의 순강이 실조하여 발생
- ③ 비위허약: 평소 비위가 허약 or 병후에 위기가 회복되지 않고 음분이 손상받음 or 찬 음식 과식하여 비양 손상하면 위허기역하여 중관을 요란하게 함
- ④ 영혈부족: 본래 체질이 비허 or 사려과다로 노상심비하거나 실혈과다하여 영혈이 부족하여 발생

## 3) 진단과 감별진단 pass

## 4) 변증시치

### (1) 위열 胃熱

|      |                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | • 조잡 + 오심 + 토산, 구갈희냉, 심번이노, 흑홍민담다<br>• 다식이기(많이 먹어도 쉽게 배고파짐), 흑 배가 고파도 고포른 것 같지 않음, 홍민불사음식, 설질홍, 설태황흑건, 맥다활삭 |
| ② 치법 | 청위강화, 和胃제담                                                                                                  |
| ③ 처방 | 온담탕                                                                                                         |

## (2) 위허 胃虛

|      |                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>위기허) 조잡시작시지, 겸 구담무미, 식후완창, 체권핍력, 설담맥허</li> <li>위음허) 흑조잡이겸구건설조, 불사음식, 흑지기불식, 식후포창, 대변건조, 설질홍, 소태흑무태, 맥세삭</li> </ul> |
| ② 치법 | 위기허는 보익위기하고 위음허는 濡養위음                                                                                                                                     |
| ③ 처방 | 사군자탕, 익위탕                                                                                                                                                 |

## (3) 혈허 血虛

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| ① 증상 | 조잡이겸면황순담, 심계두훈, 수면몽다, 기억력약, 설질담, 태박백, 맥세약 |
| ② 치법 | 익기보혈 보익심비                                 |
| ③ 처방 | 귀비탕 (활용도 높으니 알아두자)                        |

## 5) 조잡의 분류

## 6) 조잡의 치료 시 주의할 점 둘다 pass

- 대부분 비기불화 수상비허로 발병. 따라서 비기를 먼저 고려해야 함

# 식욕부진 食欲不振

〈교과서 내용 정리 p.100〉

## 1) 개요

- 음식 맛이 없다거나 굶어도 먹고 싶지 않다거나 음식 생각이 없다거나 하는 등의 식욕 저하증상을 총칭함
- 식욕은 생명을 영위하는 근본이며 건강의 척도가 됨
- 식욕부진은 소화기질환으로 발생하는 경우 많으나, 이외 많은 질환에서도 흔한 증상임
- 특별 질병이 없는데도 계속 식욕부진하면 체력저하로 질병을 초래할 수 있으므로 가볍게 다루서는 안됨

## 2) 병인병기

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 외사범위 | 육음이나 예탁한 사기가 장부에 침입하면 비위의 기능에 영향을 미쳐 비실건운하고 위실강납하여 식욕부진 발생. 특히 습사가 많음              |
| ② 음식내상 | 식부절, 기포무상, 폭음폭식으로 비위손상되어 식적停阻됨 or 비위 허약한데 생냉한량한 음식 과식하여 음한의 응체하여 수납/운화장애 초래하면 발생   |
| ③ 정지실조 | 정신적 자극으로 간기가 울열, 횡역하여 위를 침범해 수납기능 이상                                               |
| ④ 비위허약 | 체질 혹은 병후 비위기허로 수납 운화기능 감퇴 or 병후에 위음부족 or 진액의 휴손으로 위가 유윤 상실해 위조한 상태 초래하여 수납, 소화력 저하 |
| ⑤ 비위양허 | 체질 혹은 병후 비위기허로 수납 운화기능 감퇴 or 병후에 위음부족 or 진액의 휴손으로 위가 유윤 상실해 위조한 상태 초래하여 수납, 소화력 저하 |

+ 이 외 항생제 등의 약물 남용, 화학요법, 방사선 요법 발생  
= 즉 외감내상 모두 비위운화의 기능 실조하게 해 식욕부진 야기



### 3) 진단 및 감별요점

#### (1) 진단

- ① 뚜렷한 식욕감퇴와 불사음식, 食不知味가 주 증상
- ② 식후에 비만창통 오심구토 전신핍력 등 겸함
- ③ 일년 사계절 모두 발생할 수 있으나 여름에 많이 발생
- ④ 발병: 급격 or 완만.

└ 급격: 병정 짧음. 발열. 구토, 설사, 위완창통, 침력 수반

└ 완만: 병정 길,

└ 점차심해짐: 미열, 소수 수반

- ⑤ 이화학적 검사 상 이상소견 없기도 하고 위염/궤양 등의 위장병 발견될 수도

#### (2) 감별요점

|                |                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간기범위형          | <ul style="list-style-type: none"> <li>정신긴장, 정서파동과 유관</li> <li>불사음식 → 식욕상실 + 애기 구역 겸함</li> </ul>                                            |
| 비위기허형          | <ul style="list-style-type: none"> <li>음식생각 X, 배고픔 모름, 식후 완복답답+부어오름</li> <li>많이 먹으면 토하려 함, 숨이 차고 피로하고 나른</li> </ul>                         |
| 위음부족형          | <ul style="list-style-type: none"> <li>외감열병 후기 열사가 위음을 손상해 발생</li> <li>배고픔을 알지만 음식생각 없음, 입 마름, 입술과 혀가 건조</li> <li>헛구역질, 대변 말라 뭉침</li> </ul> |
| 비위허한형<br>비신양허형 | <ul style="list-style-type: none"> <li>음식 먹어도 맛이 없음, 먹으면 체한 것처럼 배가 불러옴</li> <li>= 모두 비위기허에서 유래</li> </ul>                                   |
| 상식형            | <ul style="list-style-type: none"> <li>음식 맛보고 냄새맡는것조차 싫어함. 위완 부음, 트림,</li> <li>대변냄새 고약, 비결하여 불통하기도, 설태곤적하고 탁함, 맥활</li> </ul>                |

### 4) 변증시치

#### (1) 肝氣犯胃 간기범위 : 칠정손상과 만성간염에서 자주 나타남

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ① 증상 | 불사음식, 정신억울, 흥민불서, 흑량협창통, 애기, 설질담홍, 설태박백, 맥현 |
| ② 치법 | 서간화위                                        |
| ③ 처방 | 월국환, 소요산                                    |

#### (2) 脾胃氣虛 비위기허 : 위신경쇠약증, 만성위염, 위하수, 만성간염 등에서 볼 수 있음

|      |                                                          |
|------|----------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 불사음식, 식후복창, 흑진식소허, 범범욕토, 면백신피, 권태무력, 기단나연, 설질담, 설태백, 맥완약 |
| ② 치법 | 건비익기                                                     |
| ③ 처방 | 삼령백출산, 인삼건비환                                             |

#### (3) 胃陰不足 위음부족 : 급성감염성 질환의 회복기, 만성위염, 위신경쇠약증에서 볼 수 있음

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ① 증상 | 불사음식, 구갈희음, 순홍건조, 대변건결, 소변단소, 설질홍, 설태소, 맥세삭 |
| ② 치법 | 자양위음                                        |
| ③ 처방 | 엽씨양위탕, 맥문동탕                                 |

#### (4) 脾胃虛寒 비위허한 : 궤양병, 만성위염 등에 나타남

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 음식무미, 불지기아, 평시음식초다변창민육구, 구담불갈, 사지불온, 대변稀爛而伴有未消化食物, 설질담, 설태백, 맥침세 |
| ② 치법 | 온중거한, 보기건비                                                       |
| ③ 처방 | 이중탕, 부자이중환                                                       |

#### (5) 傷食形 상식형

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| ① 증상 | 염식, 애기, 완복포창, 대변취예, 흑비결불통, 설태탁니, 맥활 |
| ② 치법 | 소식도체                                |
| ③ 처방 | 보화환, 지실도체환                          |

**(6) 脾腎陽虛 비신양허** : 心腎기능부전 및 갑상선기능감퇴, 만성부신피질기능감퇴에서 나타남

|      |                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 염식구담, 면색창백 흑암흑, 정신피로, 사지불온, 요산퇴연, 파냉, 흑지체부종, 설질담, 설체반, 맥침세약 |
| ② 치법 | 보양익기                                                        |
| ③ 치방 | 비신쌍보환, 이시환, 보진환                                             |

**(7) 外邪犯胃 외사범위** : 풍한이나 풍열 또는 서습의 증상을 수반

|      |              |
|------|--------------|
| ① 증상 | 돌연음식감소, 발병교급 |
| ② 치법 | 疏邪醒脾         |
| ③ 치방 | 곽향정기산        |

**5) 예방과 조리** pass

✓ **보비위탕**

- 비계내과에서 만든 처방
- 비위기허형 식욕부진에 가장 잘 듣는 처방
- 원육 황기 8g 구기자 당귀 백출 산약 6g  
백복령 백작약 사인 산사 생강 진피 천궁 4g 감초 대조 목향 백두구 3g  
오매 오미자 익지인 2g + 加 녹용

✓ **향사군자탕**

- 암환자분들의 후유증 증상인 식욕부진과 오심구토에 좋은 처방
- 반하 진피 백복령 백출 생강 인삼 6g 곽향 사인 신곡 지실 4g  
감초 목향 오매 2g

✓ **삼출건비탕**

- 건비양위, 운화음식
- 인삼 백출 백복령 후박 진피 산사육 4g 지실 백작약 3g 감초 사인 신곡 맥아 2g

## 만성피로

〈교과서 내용 정리 p.302〉

### 1) 개요

- 피로는 비특이적 증상이며 환자의 주관적 호소임
- 생리적 피로: 육체적 과로 후 일시적으로 나타났다가 휴식을 취하면 회복되는 정상적 생리 반응
- 급성 피로: 발병 6개월 이내의 피로
- 만성 피로: 발병 6개월 이후까지 지속되는 것

### 2) 피로가 인체에 미치는 영향

- ① 피로로 인한 생화학적 및 생리학적 변화
- ② 작업 또는 생산능력의 저하
- ③ 사고, 판단능력 저하

### 3) 피로의 원인

|           |                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 기질적 원인    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 병력이나 이학적 검사, 검사실 검사로써 질환을 인지</li> <li>• ex) 심부전, 만성폐쇄성 폐질환, 폐결핵, 당뇨병 등</li> </ul>                                      |
| 정신 사회적 원인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 가장 흔한 원인: 우울증 &gt; 불안증 &gt; 스트레스 &gt; 적응장애 등</li> <li>• 기질적 원인 환자보다 더 생생하게 피로 호소</li> <li>• 검사 소견상 아무 이상 없음</li> </ul> |

### 3) 임상양상

✓ **신체적 피로**

- 머리가 무겁다 / 머리가 아프다 / 전신이 노곤하다 / 몸 어딘가 아프고 노곤하다
- 어깨가 아프다 / 가슴 답답 / 다리가 노곤
- 침이 마른다 / 하품이 난다 / 식은 땀이 난다

### ✓ 정신적 피로

- 골치가 땡하며 얼굴이 화끈거림 / 생각하는 것 귀찮음 / 남하고 말하는 것 귀찮음
- 신경질 남 / 졸림 / 정신이 오락가락함 / 일에 열중 안됨 / 간단한 것 생각 안 남
- 하는 일에 자신이 없음 / 일하는 것 걱정됨

### ✓ 신경감각적 피로

- 눈이 피로해 잘 보이지 않음 / 눈 뻑뻑함 / 동작이 어색해 잘 틀림
- 다리가 흔들림 / 입맛이 변해 냄새가 싫어짐 / 어지러움
- 눈꺼풀이나 손에 경련이 옴 / 귀가 잘 안 들리고 귀에서 왕왕거림
- 손발이 떨림 / 가만히 있기 힘들

## 4) 만성피로증후군

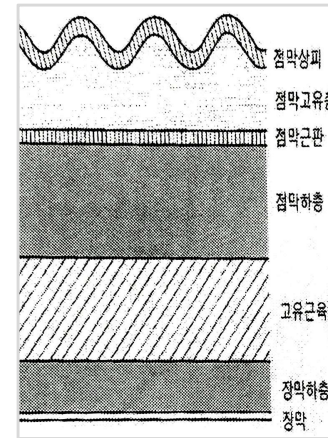
- 특별한 원인이 없으나 공통점 존재
- 공통점: 중추신경의 기능장애 / 스트레스 / 행동증상
- 면역이상, 뇌하수체 호르몬 이상, 시상하부의 이상, 신경전달물질의 이상 등을 원인으로 추측할 수 있음

# 위염과 위안통

## 위염

### 1) 위장관의 해부학적 구조

#### (1) 위장관의 구조 ★ 입 ~ 항문까지의 관상구조



Mucosa 상피, 고유층, 근층

Submucosa

Muscularis externa 내환층, 외종층

Serosa 장측복막이 구성

\* 장막: 소화관을 전체적으로 싸고 있지만 식도에는 장막 X  
= 따라서 식도에서 암 등의 변이가 생기면 타 장기로의 전이가 빠르고 천공이 생기는 등 예후가 좋지 않음

### ✓ 위장관의 혈류분포

- ① 동맥: 장간막을 통해 점막하조직에서 혈관총 형성한 후 분지들이 점막에서 모세혈관그물을 만듦
- ② 정맥: 점막하조직에서 문합하여 동맥과 함께 주행한다.
- ③ 림프관: 점막층에서 시작하여 소장에서 지방의 흡수를 담당

### ✓ 간문맥의 폐쇄된 상황

- ① esophageal venous plexus - esophageal varix
- ② rectal venous plexus - hemorrhoid

## (2) 위장관의 신경분포

|        |                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 외인성 신경 | ① 미주신경으로 이루어진 신경절전 부교감신경섬유<br>② 복강신경다발로 이루어진 신경절후 교감신경섬유                                 |
| 장내 신경총 | ① 근층간 신경총: 위벽의 근층에 있으며 섬유를 고유 근육층으로 보<br>내 위의 연동운동을 관장<br>② 점막하 신경총: 위액분비기능과 점막근의 운동을 관장 |

## (3) 위의 신경 지배 - 자율신경계 ★

|       |                                                                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 교감신경  | ① Lt. vagus nerve → ant. of stomach에 분포<br>② Rt. vagus nerve → post. of stomach에 분포 |
| 부교감신경 | 내장신경 억제작용 → 위 긴장도 저하, 유문괄약근 이완                                                      |

- 요새 자율신경실조증 이라는 진단 多
- 비계환자도 소화기 증상 외의 다른 자율신경 증상을 가지고 있음

### ✓ SP-3000, SP-6000: 양명경 경락진단 (수양명경)

- 양명경 검사를 통해 교감신경, 부교감신경, Total power 등을 수치화된 결과로 확인
- 양명경 관련하여 소화기 증상이 있는 환자에게서 85-90%의 신뢰도 확인 가능
- 초진 후 6개월 후 양명경 검사를 함

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| 부교감 - 교감신경의 균형도 | 최근의 환자 컨디션 반영                        |
| 활성도             | 환자의 근 6개월 이상의 컨디션을 반영                |
| Total Power(TP) | 환자의 기본 체력과 면역력을 나타냄                  |
| Emotional state | 환자의 우울감 나타냄                          |
| 혈관 노화도          | 1~3단계 (정상) / 4~5단계 (주의) / 6~7단계 (위험) |

### ✓ 위장관의 장내신경총

- ① Auerbach's plexus 아우에르바흐 신경총 = 근층간 신경총
  - ↳ 위벽의 근층에 있으며 위의 운동을 관장
- ② Meissner's plexus 마이스너 신경총 = 점막하 신경총
  - ↳ 위액분비기능과 점막근의 운동 관장

- 위장관의 혈액순환이 잘 되는 것이 1번임
- 즉, 위염 치료 시 기질적 증상을 완화시켜주는 약들을 생각하기 이전에 기저로 혈액순환이 잘 되어야 한다는 것을 명심!

## (4) 식도

### ✓ 생리적 기능에 따른 분류

- ┌ 상부식도괄약근: 인두와 식도를 나누고 흡기 시 식도로 공기가 들어가는 것 방지
- └ 식도체부
  - ↳ 하부식도괄약근: 위액이 식도로 역류하는 것 방지 ★

### ✓ 식도의 구조

- ① 점막: 점액선이 식도양단의 고유층에 있고, 점막근층에는 한층의 평활근이 종으로 배열
- ② 점막하조직의 상부: 점액선인 식도 고유선이 분포
- ③ 근육층: 골격근 / 내환층+외중층 / 평활근

⇒ 식도는 외막이 장막으로 구성되어 있지 않으며 식도 외벽을 둘러싸는 조직인 외막은 느슨한 결합조직으로 구성되어 있어 식도압인 경우 조기에 주위 조직으로 침습할 가능성이 높음 = 파열되기 쉽고 암의 전이도 용이함

## (5) 위 Stomach

- 본문, 위저부, 위체부, 위전정부, 유문으로 구성되어 있으며 소만과 대만, 전벽과 후벽이 이를 만들고 있음
- 위저부: 식도와 위가 만나는 점보다 위에 위치하고 있으며 약 50cc 정도의 공기포함
- 기능) 항균 / 소화 / 음식물의 저장과 배출 / 위벽의 보호 / 공복감 인지 및 내분비

## (6) 소장 - 십이지장

- 십이지장에서 가장 중요한 것은 상부
- 상부: 십이지장 구부라고도 하며 후복벽에 붙어 있지 않아서 자유로운 움직임이 가능 = 소화성 궤양이 있을 때 나타나는 부위
- 하부: 담관과 췌관이 합류하는 팽대부가 있는 곳. 우신동정맥 및 우신의 앞에 위치 = 임상적으로 중요한 위치

## 2) 위장관의 정상내시경상 프린트로 사진 확인해주세요!

|      |                                                   |
|------|---------------------------------------------------|
| 위각부  | 정상 위각은 부드러운 화모양을 보이며 두껍지 않음                       |
| 체부   | 위대만부의 정상 점막 주름                                    |
| 유문부  | Scope를 빼며 유문동 전체를 관찰함. 정상 점막은 요철이 없고 혈관투시도 보이지 않음 |
| 위소구  | 위점막은 성인이 되면 위소구가 형성됨                              |
| 외부압박 | 위체부에 비장에 의한 압박 소견                                 |

⇒ 미담홍색의 맨질맨질 매끈한 모양새임

## 3) 위염의 내시경적 분류

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 발적/삼출성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>가장 흔함 / 발적반 / 결절상 / 광택 소실 / 삼출물의 부착</li> <li>점막 유약성 동반 / 전정부, 체부에 동시에 관찰</li> <li>전정부에 유문륜 쪽으로 향하는 선상의 발적이 관찰</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 편평 미란성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>편평 미란이 주된 이상 / 단독 or 다발성</li> <li>전정부에 국한되기도 하고 위 전체에 형성되기도 함</li> <li>유문륜으로 향하는 주름을 따라 선상으로 배열되기도 함</li> <li>주변에 발적을 동반한 편평 미란이 관찰됨</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 융기 미란성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>위점막 주름을 따라 발생되기도 함 / 발적동반 흔함</li> <li>염주알 모양으로 연결되어 나타나는 경우 多</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 위축성 위염 ★  | <ul style="list-style-type: none"> <li>위가 과신전되지 않은 상태에서 점막의 혈관상이 관찰되는 경우 유백색의 색조변화와 점막주름이 위축되어 있음</li> <li>혈관 투영성 정도에 따라 경/중등/중증 으로 나뉨</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>위염 진단 받고 한의원 내원하는 환자 대부분이 위축성 위염 딱히 치료법 제시되어 있지 않음</p> <p>📖 <b>위축성 위염 case</b></p> <p>54세 남성. 술담배 O. 위축성 위염 진단 받고 내원.<br/>한 달정도 침+약치료, 한달 후 불편한 증상 소실 - 이후 한 달에 한 번씩 한약만 처방해감. 예후 좋고 망진에서 얼굴색이 너무 좋아졌으며, 체중도 6-7kg 빠짐.</p> </div> |

|           |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 출혈성 위염    | <ul style="list-style-type: none"> <li>염증성 소견 외에 위점막에 적색/흑갈색의 점상 또는 반상 출혈점이 있을 때 진단 가능</li> <li>검은색 물질이 위벽에 묻어 있거나 혈액이 위강 내에서 관찰</li> <li>아스피린, 엔세이드, 약물 복용에 의해 발생해 내원하기도</li> </ul>                      |
| 비후성 비염    | <ul style="list-style-type: none"> <li>체부의 점막 주름이 현저하게 비후되어 있을 때</li> <li>공기를 주입하여도 주름이 잘 펴지지 않음</li> <li>간혹 비후된 점막 주름이 용종 모양으로 불규칙하거나 미란이 동반되는 경우도 있음</li> <li>충분한 공기가 주입된 후에도 현저한 점막 비후가 관찰됨</li> </ul> |
| 장액 역류성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>담즙 역류에 의해 발생하며 발적 삼출성 위염의 변형임</li> <li>위점막에 역류된 담즙이 묻어 있고 분명한 발적과 부종이 동반된 경우에 진단함</li> </ul>                                                                       |

### ✓ 급성 위점막 병변 ★

- 급격한 위증상을 동반하고 내시경에 의해 위점막에 이상 소견이 나타나는 병변
- 한국성 또는 미만성의 급성 미란성 위염
- 단발 및 미만성의 급성 위궤양
- 출혈성 위염을 말하며 이들 병변이 서로 섞여 있음

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 증상 | 급격한 심와부통 / 출혈 / 오심구토 / 식욕부진 / 상복부 팽만감 / 토혈 / 하혈                                       |
| 진단 | 위비관 내시경 시행                                                                            |
| 원인 | 약물, 기호품, 스트레스, 간경변, 요독증, 당뇨병, 백혈병, 방사선, H.pylori                                      |
| 치료 | 우선 원인 제거 → 출혈의 경우 내시경적 지혈<br>→ 보존적 치료: 위 편안히 함(금식) / 위산의 조절 / 복통경감 / 안정 / 수액보충 / 식사요법 |
| 경과 | 양호                                                                                    |

- 급격한 스트레스 or 음주와 약물의 동시 복용 or 공복에 약물 복용 등으로 인해 발병
- 음식과 수액 보충이 중요 - 2~3일 입원 시 좋아짐. but 위염이 같이 있었던 경우에는 회복하려면 6주, 타조직까지 전부 회복하려면 6개월 정도 걸림 (3개월 정도 관리 잘해야 함)

#### 원로 디자이너의 급성 위점막 병변 case

교수님께서 아시는 원로 디자이너분이 모델을 보는 데에 굉장한 stress로 인해 진통제 같은 약을 복용하였는데, 이후 새벽 2시에 엄청난 복통을 호소하며 교수님께 전화함. 교수님은 전화 받고 내시경 권함. 알고보니 거의 천공 직전까지 갔었음. 현재는 호전됨

## 급성 위염

- 위점막에 급성으로 염증성 변화를 보이는 것
- 보통은 무증상이며 임상적 의의로는 대부분 합병증이 있을 때
- 점막의 충혈, 부종, 간질에서 호중구를 위주로 하는 염증성 세포침윤, 피복상피 및 선상피의 점액분비 항진, 상피의 박리, 미란, 점막괴사를 초래함

✓ 소화성 궤양 중 급성 궤양의 특수성 - 스트레스성 궤양

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Cushing's Ulcer | 중추성 장애에 동반되는 소화성 궤양<br>병변으로 급성 위궤양과 위출혈성 미란이 많음 |
| Curling's Ulcer | 열성 화상에 동반되는 소화성 궤양<br>병변으로 급성 위궤양과 위출혈성 미란이 나타남 |

### 1) 급성 위염의 원인

- 폭음, 폭식, 과열/과냉의 음식물 섭취, 부패성 음식이나 알레르기성 음식물 섭취, 치아가 나빠서 음식물을 충분히 씹지 못하고 삼킨 경우
- 기타 유발 인자: 급성 알코올 중독 / shock / 약물 / 급성열성질환 / 요독증 / 중금속 중독 / 결핵 / 매독 / 폐렴 등

### 2) 증상

- 식욕부진 / 구역 / 구토 / 광범위한 상복부 불쾌감 / 복통
- 때로 발열, 신전출혈 / 알코올 중독자에 있어서는 특별한 위증상 없이 갑작스런 출혈

- |        |            |              |
|--------|------------|--------------|
| ① 傷食證形 | ③ 알레르기형    | ⑤ 위장염형       |
| ② 주상證形 | ④ 약물에 의한 형 | ⑥ 부식 감염 화농성형 |

### 3) 감별진단 충수돌기염만 언급하심

- 충수돌기염: 초기에는 복부 또는 상복부 동통이 있으며 동통이 점차 우상복부, 특히 Mc Burney's point로 이동함
- 그 외에 다른 임상소견과 자세한 장기감별이 필요  
↳ 현재는 금방 구별이 되나, 예전에는 감별진단이 잘 되지 않아 복막염까지 오기도 ..

### 4) 치료

- 원인 제거 → 이후 보존적 치료 (대부분의 경과가 자연치료 되는 경우 多)
- 안정과 식사의 주의로 치료해야 함
- 음식 조절만 해도 많이 좋아짐

## 만성 위염

### 1) 원인

- ① H.pylori - 위축성 위염의 경우 100% 감염되어 있음
- ② 급성 위염에서 이행, 내상에 의하여 발병
- ③ 신체의 허약, 감정장애
- ④ 위암, 위궤양, 십이지장위역류, 갑상선 질환 ... 등
- ⑤ 심장병, 고혈압 등으로 위장의 율혈이 지속됨에 따라 만성 위염 발생

### 2) 분류

- ┌ 조직학적 특징에 따른 분류 ) 표층성 위염 / 위축성 위염 / 위위축
- └ Schindler 분류 ) 표층성 위염 / 위축성 위염 / 비후성 위염

✓ 조직학적 특징에 따른 분류 설명하신 것만 정리

|        |                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 표층성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>카타르성 위염</li> <li>위점막의 염증, 결손, 재생의 반복으로 나타남</li> <li>점막 세포 생성층의 유양사, 표층상피의 미란 등 침해가 가벼운 경우</li> <li>병변) 위체하부 미만성이나 국한적인 부위도 나타날 수 있음<br/>+ 국한성의 점막출혈, 수종 혹은 출혈점 수반</li> </ul> |
| 위축성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>재생속도에 비해 결손 속도가 빠름</li> <li>염증이 상당히 오래전부터 있었어서 점막이나 그 아래의 조직이 위축되어 얇아진 상태</li> <li>위축성 위염을 10년 혹은 그 이상 경과 관찰 시 2/3에서는 변화가 없고 나머지는 퇴행/진행되어 선암은 10%에서 발생</li> </ul>            |
| 장상피 화생 | <ul style="list-style-type: none"> <li>위축성 위염의 과정에서 위축된 위점막이 장상피로 치환되어 현미경적으로 술잔세포가 나타나는 것이 특징이고 위암과 밀접한 관련 O</li> </ul>                                                                                            |
| 위위축    | <ul style="list-style-type: none"> <li>위축성 위염이 진행되어 발생</li> <li>점막이나 그 아래 조직이 위축되어 얇아지며 특수 변화 세포는 완전히 소실되어 무산증이 나타남</li> </ul>                                                                                      |

✓ Schindler 분류

|        |                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 비후성 위염 | <ul style="list-style-type: none"> <li>체부 선 점막의 단순한 증식이며 고유 선세포인 주세포, 벽세포 및 선와상피는 정상적 비율을 유지하여 결과적으로 점막이 비후되는 병변</li> </ul> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

✓ 만성 위염의 부위에 따른 분류

|        |                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| type A | <ul style="list-style-type: none"> <li>기저부와 body에 발생</li> <li>벽세포와 intrinsic factor에 대한 항체 혈중에서 검출</li> <li>자가면역기전에 의한 A형 만성 위염은 악성 빈혈과 관계 있음</li> </ul> |
| type B | <ul style="list-style-type: none"> <li>위전정부에 주로 발생 / H.pylori 감염이 주 원인</li> </ul>                                                                        |
| type C | <ul style="list-style-type: none"> <li>유문을 통해 십이지장 내용물이 위로 역류됨으로 생김</li> <li>유문부나 십이지장의 운동이 감소된 경우 흔함<br/>= 담즙 역류성 위염</li> </ul>                         |

3) 증상

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 대부분 증상 X or 간헐적/지속적인 막연한 고통                |
| 식욕감퇴 / 음식 보거나 냄새만 맡아도 구역질 / 조금만 먹어도 만복감 O  |
| 위 부근의 불쾌감, 압박감 / 쑤시는 동통 / 광범위한 심부의 불쾌감 속쓰림 |
| erosion의 경우 위부의 동통 자각 / 애기, 탄산, 조잡 등       |

4) 진단 내시경으로 확진됩니다! 하고 pass하심

5) 합병증, 치료 pass

6) 변증시치

|        |        |        |
|--------|--------|--------|
| ① 간위불화 | ③ 위음부족 | ⑤ 간위습열 |
| ② 비위허약 | ④ 어혈조락 |        |



## 위완통 교과서 정리 p.141

### 1) 개요

|    |                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 정의 | <ul style="list-style-type: none"> <li>심와부 이하 제부 이상의 부위에서 통증이 발생하는 것</li> <li>통증은 다양한 양상을 나타냄</li> <li>수반 증상: 완복창민, 불사음식, 탄산, 오심, 조잡, 대변혹결혹당, 흑토혈변혈 등</li> </ul>                                                            |
| 원인 | <ul style="list-style-type: none"> <li>대개 憂思鬱怒로 간목이 횡역하여 위를 범하거나 음식노권으로 비위의 기를 손상하여 발생</li> <li>병정이 오래되면 기울화하여 한열협작하거나 기병급혈 하게됨 이후 점차 비위양허/간위음허로 발전하여 담/어/체를 끼게 됨</li> <li>비위의 納化 기능의 손상과 기혈운행 장애는 각종 위완통의 기본 병리</li> </ul> |

### 2) 병인병기

|              |                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鬱怒傷肝<br>간기범위 | <ul style="list-style-type: none"> <li>憂思惱怒로 간기가 울체하여 소설 기능이 실조해 위를 침범하면 기혈이 응체하여 불통하므로 통증 발생</li> <li>간기의 울결이 오래되면 化火</li> </ul>                                             |
| 음식부절<br>손상비위 | <ul style="list-style-type: none"> <li>폭음폭식과 기포무상은 비위의 기를 가장 잘 손상시킴</li> </ul>                                                                                                |
| 稟賦부족<br>비위허약 | <ul style="list-style-type: none"> <li>본래 비위가 허약하거나 노권으로 내상을 입거나 구병이 낮지 않고 비위에 영향을 미치거나 혹은 용약이 부당하다면 모두 비위를 손상할 수 있음</li> <li>운동은 치료 효과를 훨씬 높여주므로 운동을 권해야 함 + 식이조절</li> </ul> |

### 3) 진단 및 감별진단

#### ✓ 진단

- 위완동통이 주 증상 + 창통, 자통, 은통, 극통 등으로 다양
- 수반증상: 완민창만, 애부탄산, 오심구토, 불사식, 대변혹결혹당 등의 비위 증상
- 전신증상: 신권필력, 면황, 소수, 부종

#### ✓ 감별진단

#### (1) 심통 VS 위완통

|       | 심통                                                                          | 위완통                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 통증 부위 | 흉중                                                                          | 위완                                          |
| 통증 양상 | 칼로 베는 것처럼 켕기고 급하며<br>통증이 가슴과 등으로 관통<br>발작할 때 심계, 별민함<br>환자는 항상 빈사상태의 감각을 느낌 | 둔통/은통이 많음<br>자통과 같은 극렬한 통증이 있으나 심통처럼 심하진 않음 |
| 예후    | 병정이 위중                                                                      | 예후 좋음                                       |

#### (2) 복통 VS 위완통 - 부위로 구별

- 위완 = 분문부(상완) + 유문부(하완) + 중완(상완과 하완의 중간)
- 위통: 완복부 통증

### 4) 변증요점과 치료원칙

✓ 변증요점: 완급 / 한열 / 허실 / 기혈을 가린다.

✓ 치료원칙: 기본적 병리는 승강실조와 기혈어조불창 즉 불통즉통!  
↳ 대부분의 치료는 통법을 써서 기혈을 조창시켜야 함

- 소화기 증상은 단순 내과질환일뿐만 아니라 근골격계의 형태와 밀접한 관계가 있기 때문에 내장기 추나가 중요함
- 전신 증상이 있는 소화기 증상 환자의 경우 침 + 추나 시 호전도가 좋다.

### ☞ 의사선생님 추나 호전 case

체중감소, 병에 대한 두려움 등으로 항상성이 떨어지는 악순환의 의사환자. 불면증, 공황장애 등 여러 가지 증상이 있었는데 교수님이 추나해줘서 많이 좋아짐

### ☞ 84세 식체 할머니 case

먹은 것도 없는데 원인 없이 갑자기 못 먹고 사지무력하며 못 걸겠다고 내원.

입원시키고 전공의가 침을 놔는데 조금 급하게 놔나봄. 이후 설사도 하는 증상 보임  
외래 때 침/부항/사혈 전부 거부했는데 교수님이 달래서 함. 지양, 신주 부항 사혈하자마자  
어르신이 트름 한 번 딱 함

= 교수님동절 - 먹은 것 없었다고 했는데 이것은 분명 식체로 인한 것인데.. 하고 다시 문진  
그제서야 어르신 생선, 회, 떡, 막걸리 먹었다고 실토.. 즉 식체였음. 원인 찾는게 중요!

## 5) 변증시치

### (1) 寒凝氣滯 한응기체

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| ① 증상 | 위통복작, 동통극렬, 외한희온, 득열통감, 구불갈, 희열음, 설태백, 맥현긴 |
| ② 치법 | 온위산한, 행기지통                                 |
| ③ 치방 | 양부탕                                        |

### (2) 飲食積滯 음식적체

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 불위완창만동통거안, 애부탄산, 흑구토불소화음식, 토후교서, 불사음식, 대변불상, 설태후니, 맥활 |
| ② 치법 | 소도행체, 화위지통                                            |
| ③ 치방 | 보화환                                                   |

### (3) 肝鬱氣滯 간울기체

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| ① 증상 | 위완창만, 통련양협, 희태식, 번뇌울노이통작, 태박백, 맥현 |
| ② 치법 | 소간이기, 화위지통                        |
| ③ 치방 | 시호소간음                             |

### (4) 痰濕中阻 담습중조

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| ① 증상 | 경측위완민통, 시작시지, 납매구점, 구즉비만창통, 오심이해, 구토청연 |
| ② 치법 | 건비화담, 이기화위                             |
| ③ 치방 | 도담탕                                    |

### (5) 瘀血阻絡 어혈조락

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 위완통여침자흑도자(칼로 찌르듯 아픔), 통처고정, 거안, 흑건구토흑변, 설질자암, 흑유어반, 맥삽 |
| ② 치법 | 활혈화어                                                   |
| ③ 치방 | 실소산, 혈부축어탕, 격하축어탕                                      |

### (6) 肝胃積熱 간위적열

|      |                              |
|------|------------------------------|
| ① 증상 | 위완작통, 흥협만민, 탄산조잡, 심번이노, 구건구고 |
| ② 치법 | 청간사화, 화위지통                   |
| ③ 치방 | 청열해울탕                        |

### (7) 脾胃虛寒 비위허한

|      |                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------|
| ① 증상 | 위완은은작통, 면면불작, 희온희안, 득식즉감, 시토청수, 납소, 핍력신평, 수족불온, 대변희당, 설질담, 맥세약 |
| ② 치법 | 온양익기건중                                                         |
| ③ 치방 | 황기건중탕                                                          |

### (8) 胃陰不足 위음부족

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| ① 증상 | 위완은은번통, 번갈사음, 구조인건, 식소, 대변건, 설홍소태, 맥세삭, 흑세현 |
| ② 치법 | 양음익기                                        |
| ③ 치방 | 익위탕 합 죽엽석고탕                                 |

## 6) 위완통과 심통의 분류

(1) 위완통: 식적 / 담음 / 어혈로 발생하는 것으로 분류 가능

### (2) 심통

- 심포락은 위구와 더불어 상응하므로 종종 비의 통증이 심장까지 이어지며 혹은 양허하여 음결이 되어도 오목가슴이 급통하게 됨

✓ **구중심통** - 中 5가지만 언급하심

- ① 충심통
- ② 주심통 (요산 거의 없음)
- ③ 풍심통: 위장관 운동성과 연관 有  
↳ 변비 질환 등에 약을 쓸 때 강할 방풍 등을 써 위장관 운동성을 높여준다.
- ④ 계심통
- ⑤ 식심통: 음식 관련 지양혈로 치료  
↳ 신주혈 통증이 심하다면 정신적 stress나 간기울결이 심한 것  
+ 중풍 환자의 재활 치료에 몸의 기동인 신주혈과 명문혈 치료를 해줌  
+ 성장통 있는 아이들에게는 신주혈 자극 + 녹용약침

✓ **육중심통**

- ① 비심통: 체장질환으로 추측 가능
- ② 위심통
- ③ 신심통: 가슴과 등이 서로 당기고 아프며 마치 등 뒤를 건드리는 것 같음  
= 척추질환의 양상을 띠
- ④ 적심통 ㄱ
- ⑤ 꺾심통 ㄴ = “심장통”
- ⑥ 진심통 ㄷ

✓ **량부환 良附丸**

- 고량강(온위산한) 향부자(소간행기)
- 적응증: 한응기체로 인한 완복협륵통
- 효능: 온중산한, 행기지통
- 주치: 한응기체 위완동통, 득온통감, 설태, 완복창만, 늑완통, 복통, 위통, 경통

✓ **백합삼합탕 白合三合湯** - 어혈증이 현저히 있을 때 사용

- 백합 단삼 오약 향부자 고량강 백단향 사인
- 주치: 한열허실협잡 기체혈어 위완통 구불유
- 고질적 위장병에 씀
- 추울 때 통증이 심한 경우: + 고량강 사인 or 오수유 건강
- 흥민 오심 변당: 진피 반하 백복령 목향
- 스트레스: - 고량강 + 향부자, 시호 백작약 후박 천련지
- 위중작열: 사삼 맥문동 지모, 황금 황련
- 변흑: 백급

✓ **통변방 通便方**

- 위완통, 위통의 원인 중 하나가 대변불통 (특히 중풍환자)
- 심위통 - 토법과 하법을 하여 대변을 통하게 하는 것이 좋음 or 이 처방 씀
- 백출 생지황 강활 방풍 대황
- 일주일 이상 스스로 통변할 수 있게 해주는 처방으로, 강활과 방풍이 위장관의 장 운동성에 관여함.